2 级高血压中西医结合诊疗指南

编制说明

提出单位：山东中医药大学附属医院

山东大学齐鲁医院

归口单位：中华中医药学会

主要起草单位：山东中医药大学附属医院

山东大学齐鲁医院

主要起草人：李运伦 卜培莉 薛一涛 朱明军 翟静波 张红星 徐浩 赵海滨 戴小华 刘春萍 刘海波 于丽平 李晓鲁 李军 王佑华 谢文 陈伯钧 王永生 岳小强 杨佃会 樊官伟 周雪忠 贺立娟 焦华琛 张玉娇 张磊

二〇二三年一月

目次

一、工作简况……1
二、指南编制原则和关键技术内容……2
三、主要工作过程……2
四、与国内外同类指南的对比和最新指南采用情况……87
五、与现行强制性国家标准或政策法规的关系……88
六、代表性分歧意见的处理经过和依据……88
七、宣传、贯彻指南和后效评价指南的要求和措施……88
八、废止现行有关指南的建议……89
九、附录……89

《2 级高血压中西医结合诊疗指南》指南编制说明

一、工作简况

1.任务背景

高血压是临床常见慢性病，也是心脑血管病最主要的危险因素。2002—2015 年间我国开展了三次高血压抽样调查（2002 年、2012 年、2015 年），粗患病率分别为 18.8%、25.2%、27.9%，人群高血压患病率总体呈上升趋势。据此推算，约四分之一的成人是高血压患者，总患病人数达 2.45 亿。2017 年，中国有 254 万人死于高收缩压，其中 95.7%死于心血管病。2013 年由高血压带来的直接经济负担达 2103 亿元，占中国卫生总费用的 6.61%,给社会及经济带来沉重负担，高血压防治任务任重而道远。中西医结合是当前临床医学的发展趋势，推动了医学水平的整体提高。2 级高血压在中医学属于“眩晕”、“头痛”、“头风”和“风眩”的范畴，是高血压病控制的重点，是疾病进展的关键阶段。中西医结合治疗已经取得了较好的成绩，在医学领域占据重要地位。但目前在中西医结合治疗 2 级高血压方面缺乏必要的基于“中西医结合诊疗”理念的可用于指导临床诊疗的标准规范。为发挥中西医结合治疗 2 级高血压的优势，提高中医药防治 2 级高血压的水平，规范中医药在治疗 2 级高血压中的应用，山东中医药大学附属医院在中华中医药学会的指导与领导下组织相关专家，参照国际最新的临床实践指南制订方法，并在相关法律法规和技术文件指导的框架下，以中西医结合诊疗理念为核心，以传统中医辨证论治及西药常规治疗为基本点，结合循证医学原理，在古今文献回顾分析、临床流行病学调查、专家咨询等系统研究工作基础上，对 2 级高血压的流行病学特点及危害、病因病机特点、证候类型、中医药干预措施、2 级高血压中西医结合诊疗等进行了梳理、归纳、总结，征询行业内部分专家意见，形成了《2 级高血压中西医结合诊疗指南》研究框架，以期为从事高血压防治的中医、中西医结合临床医师提供指导性意见。

2.任务来源

本项目是由山东中医药大学附属医院、山东大学齐鲁医院申请，由中华中医药学会立项。

3.指南起草单位

本共识由山东中医药大学附属医院、山东大学齐鲁医院起草。参与起草单位包括：山东中医药大学附属医院、山东大学齐鲁医院、河南中医药大学第一附属医院、天津中医药大学、济南市中医医院、中国中医科学院西苑医院、北京中医药大学东方医院、安徽中医学院第一附属医院、解放军总医院第七医学中心、复旦大学附属中山医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、山东第一医科大学第一附属医院、中国中医科学院广安门医院、上海中医药大学附属龙华医院、成都中医药大学附属医院（四川省中医院）、广东省中医院、南京中医药大学附属医院、天津中医药大学第一附属医院、海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）、山东中医药大学、天津中医药大学第一附属医院、北京交通大学。

二、指南的编制原则和关键技术内容

1.指南的编制依据和原则

本共识的编制流程和方法依据《中华中医药学会中医指南制定的技术方案》。

本共识参照《世界卫生组织指南制定手册》的标准制定流程以及GRADE系列文章的方法，通过文献检索筛选整理循证医学证据，根据循证等级标准对文献质量进行评价分级，制订了本方案的草案，文本撰写所依据的原则，例如《标准化工作导则标准的结构和编写GB/T1.1-2009》、《中华中医药学会中医指南报告清单》。

2.指南的关键技术内容

本共识给出了2级原发性高血压的诊断标准、中医辨证标准、中西医结合治疗方案的内容，包括指南问题、推荐意见、共识建议、辨证分型、治疗原则、治疗方法、预防与调摄等。适用于2级原发性高血压的中西医结合诊断与治疗。适合各级医疗机构中从事高血压临床工作的相关人员使用。

3.修订指南时，应增列新旧指南水平的对比。

三、主要工作过程

（一）提案、申请、立项

提案：2022年2月，李运伦教授在山东中医药大学附属医院召开“2级高血压中西医结合诊疗指南”项目讨论会，会议确定向中华中医药学会标准化办公室申请《2级高血压中西医结合诊疗指南》的立项，并确立了由临床医师、药学专家、方法学专家等共同构成起草组。

申请：2022 年 3 月向中华中医药学会标准化办公室提交《2 级高血压中西医结合诊疗指南》立项申请材料。

立项：2022 年 4 月 1 日，中华中医药学会组织召开团体标准立项论证会，《2 级高血压中西医结合诊疗指南》通过立项论证。会后按照专家意见对立项申请书进行完善，经中华中医药学会秘书长办公会审议批准，于 2022 年 4 月 12 日发文正式立项（立项公告详见附件 1）。

（二）成立指南起草组

1.指南起草组成立方式

2022 年 3 月 10 日李运伦教授召集并在山东中医药大学附属医院召开“2 级高血压中西医结合诊疗指南”项目组织管理讨论会，诊疗方案秘书详细介绍项目任务与计划安排，会议确定本诊疗方案设置起草工作组、系统评价小组、诊疗方案会议专家组、指导委员会、秘书处。

2.指南起草组组成情况

（1）指南起草组组成情况

指南起草组主要包括主审专家、方法学专家、疾病领域专家委员会、药学领域专家委员会、主要起草人、其它起草人、其他专家、系统评价组及秘书处。

（一）主审专家

丁书文 山东中医药大学附属医院

陈玉国 山东大学齐鲁医院

（二）方法学专家

翟静波 天津中医药大学

周雪忠 北京交通大学

（三）疾病领域专家委员会

李运伦、卜培莉、薛一涛、朱明军、徐浩、赵海滨、戴小华、刘春萍、刘海波、于丽平、李晓鲁、李军、王佑华、谢文、陈伯钧、王永生、岳小强、杨佃会、樊官伟、周雪忠、贺立娟、焦华琛、张玉娇、张磊

（四）药学领域专家委员会

张红星 济南市中医医院

（五）主要起草人

李运伦 山东中医药大学附属医院

卜培莉 山东大学齐鲁医院

薛一涛 山东中医药大学附属医院

朱明军 河南中医药大学第一附属医院

翟静波 天津中医药大学

张红星 济南市中医医院

（六）其他起草人

徐 浩 中国中医科学院西苑医院

赵海滨 北京中医药大学东方医院

戴小华 安徽中医药大学第一附属医院

刘春萍 解放军总医院第七医学中心

刘海波 复旦大学附属中山医院

于丽平 首都医科大学附属北京朝阳医院

李晓鲁 山东第一医科大学第一附属医院

李 军 中国中医科学院广安门医院

王佑华 上海中医药大学附属龙华医院

谢 文 成都中医药大学附属医院

陈伯均 广东省中医院

王永生 南京中医药大学附属医院

岳小强 海军军医大学第二附属医院

杨佃会 山东中医药大学

樊官伟 天津中医药大学第一附属医院

周雪忠 北京交通大学

贺立娟 北京中医药大学东方医院

焦华琛 山东中医药大学附属医院

张玉娇 山东第一医科大学第一附属医院

张 磊 山东中医药大学附属医院

陈建新 北京中医药大学

曹克刚 北京中医药大学东直门医院

鹿庆华 山东大学第二医院

胡德胜 华中科技大学同济医学院附属协和医院

陈 广 华中科技大学同济医学院附属同济医院

周迎春 南方医科大学南方医院

何 佳 南方医科大学珠江医院

肖长江 湖南省中医药研究院附属医院

王肖龙 上海中医药大学附属曙光医院

薛金贵 上海中医药大学附属曙光医院

吴美平 上海中医药大学

孙永宁 上海市中医医院

晋 群 中国人民解放军联勤保障部队第 960 医院

苑海涛 山东省立医院

蒋绍博 山东省立医院

谢静远 上海交通大学医学院附属瑞金医院

童 丽 青海大学医学院

乔海法 陕西中医药大学

王 磊 广东省中医院

高嵩山 黑龙江中医药大学附属医院

曲政军 济南市中医医院

赵 凌 成都中医药大学

付长庚 中国中医科学院西苑医院

王 蕾 首都医科大学

曹 鹏 南京中医药大学

季旭明 浙江中医药大学

岳桂华 广西中医药大学国际壮医医院

（七）其他专家

崔向宁、马慧研、张新元、马俊、王世钦、杨文、马传江、王洋、李峥、刘光辉、安贵鹏、刘春晓、孙厚荣、孟祥斌、王欣、王永梅、李欣然、李焱、赵浩、

马建亮、仝永利、周立志、赵泽英、辛锐、何超文、张明、孙宏岗、陈扶虎、张俊、唐海飞、冯晓敬、鞠建庆、谢振东、王敏、韩博、薛江博、刘伟也参与临床问题调研、专家访谈、方案的起草与制定工作。

（七）系统评价组

滑 振 山东中医药大学附属医院

朱羽硕 山东中医药大学附属医院

王海权 山东中医药大学

武玉洁 山东中医药大学

殷弘琳 山东中医药大学

王靖涵 山东中医药大学

李思璇 山东中医药大学

张沐欣 山东中医药大学

马勇博 山东中医药大学

张鑫荣 山东中医药大学

刘丽珠 山东中医药大学

（九）秘书组

朱羽硕、滑振、齐于辰、辛来运、王晓杰、胡渊龙

（2）指南起草组成员名单及分工

以表格形式列出，见表 1。

表 1 指南起草组成员及其工作内容

序号	姓名	单位	职务/职称	专业	学位	工作内容
1	李运伦	山东中医药大学附属医院	主任医师	中医内科学	博士	牵头专家
2	卜培莉	山东大学齐鲁医院	主任医师	心内科	博士	牵头专家
3	朱明军	河南中医药大学第一附属医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
4	薛一涛	山东中医药大学附属医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会

5	翟静波	天津中医药大学	研究员	中西医结合	博士	参加专家会
6	张红星	济南市中医医院	主任医师	中药学	博士	参加专家会
7	徐 浩	中国中医科学院西苑医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
8	赵海滨	北京中医药大学东方医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
9	戴小华	安徽中医药大学第一附属医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
10	刘春萍	解放军总医院第七医学中心	主任医师	心内科	博士	参加专家会
11	刘海波	复旦大学附属中山医院	主任医师	心内科	博士	参加专家会
12	于丽平	首都医科大学附属北京朝阳医院	主任医师	心内科	博士	参加专家会
13	李晓鲁	山东第一医科大学第一附属医院	主任医师	心内科	博士	参加专家会
14	李 军	中国中医科学院广安门医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
15	王佑华	上海中医药大学附属龙华医院	主任医师	心内科	博士	参加专家会
16	谢 文	成都中医药大学附属医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
17	陈伯均	广东省中医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
18	王永生	南京中医药大学附属医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
19	岳小强	海军军医大学第二附属医院	主任医师	心内科	博士	参加专家会

20	杨佃会	山东中医药大学	主任医师	针灸科	博士	参加专家会
21	樊官伟	天津中医药大学第一附属医院	主任医师	中西医结合	博士	参加专家会
22	周雪忠	北京交通大学	研究员	方法学	博士	参加专家会
23	贺立娟	北京中医药大学东方医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
24	焦华琛	山东中医药大学附属医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
25	张玉娇	山东第一医科大学第一附属医院	副主任医师	心内科	博士	参加专家会
26	张 磊	山东中医药大学附属医院	副主任医师	中医内科学	博士	参加专家会
27	陈建新	北京中医药大学	教授	方法学	博士	参与调研
28	曹克刚	北京中医药大学东直门医院	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
29	鹿庆华	山东大学第二医院	主任医师	心内科	博士	参加调研
30	胡德胜	华中科技大学同济医学院附属协和医院	主任医师	心内科	博士	参加调研
31	陈 广	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主任医师	心内科	博士	参加调研
32	周迎春	南方医科大学南方医院	主任医师	心内科	博士	参加调研
33	何 佳	南方医科大学珠江医院	主任医师	心内科	博士	参加调研
34	肖长江	湖南省中医药研究院附属医	主任医师	中医内科学	博士	参加调研

		院				
35	王肖龙	上海中医药大学附属曙光医院	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
36	薛金贵	上海中医药大学附属曙光医院	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
37	吴美平	上海中医药大学	研究员	中医内科学	博士	参加调研
38	孙永宁	上海市中医医院	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
39	晋 群	中国人民解放军联勤保障部队第 960 医院	主任医师	心内科	博士	参加调研
40	苑海涛	山东省立医院	主任医师	心内科	博士	参加调研
41	蒋绍博	山东省立医院	主任医师	心内科	博士	参加调研
42	谢静远	上海交通大学医学院附属瑞金医院	主任医师	心内科	博士	参加调研
43	童 丽	青海大学医学院	主任医师	心内科	博士	参加调研
44	乔海法	陕西中医药大学	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
45	王 磊	广东省中医院	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
46	高嵩山	黑龙江中医药大学附属医院	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
47	曲政军	济南市中医医院	主任医师	中医内科学	硕士	参加调研
48	赵 凌	成都中医药大学	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
49	付长庚	中国中医科学院西苑医院	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
50	王 蕾	首都医科大学	主任医师	心内科	博士	参加调研

51	曹 鹏	南京中医药大学	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
52	季旭明	浙江中医药大学	主任医师	中医内科学	博士	参加调研
53	岳桂华	广西中医药大学国际壮医医院	主任医师	中医内科学	博士	参加专家会

3.利益冲突声明

本诊疗方案获得齐鲁中医药优势专科集群建设项目、山东省卫健委中西医结合高血压建设项目（2019-11）、山东省重大科技创新工程项目（2021SFGC0503）资助。本诊疗方案项目组成员在项目正式启动前均签署了“利益冲突声明书”，且已存档。本诊疗方案制定过程中“无利益冲突”，为此不会成为本诊疗方案制定的偏倚来源，无需进一步处理，已在正式工作开始前在会议上公开了利益声明和评价结果，即所有参与本诊疗方案制定的成员均和药品生产企业没有任何经济利益往来。

（三）确定指南的题目和范围

高血压是临床常见慢性病，也是心脑血管病最主要的危险因素。2013 年由高血压带来的直接经济负担达 2103 亿元，占中国卫生总费用的 6.61%,给社会及经济带来沉重负担，高血压防治任务任重而道远。中西医结合是当前临床医学的发展趋势，推动了医学水平的整体提高。2级高血压在中医学属于“眩晕”、“头痛”、“头风”和“风眩”的范畴，是高血压病控制的重点，是疾病进展的关键阶段。中西医结合治疗已经取得了较好的成绩，在医学领域占据重要地位。但目前在中西医结合治疗 2 级高血压方面缺乏必要的基于“中西医结合诊疗”理念的可用于指导临床诊疗的标准规范。

为发挥中西医结合治疗 2 级高血压的优势，提高中医药防治 2 级高血压的水平，规范中医药在治疗 2 级高血压中的应用，山东中医药大学附属医院向中华中医药学会提出申请，在学会指导下，专家组共同商议确定《2级高血压中西医结合诊疗指南》的指南题目。在专家访谈及临床调研基础上，并多次展开专家谈论会，确定本共识的范围。

（四）构建指南问题

1.专家访谈

（1）访谈方案确定过程及方法

为梳理诊疗方案结构，提炼标准问题，特向本学科领军专家发出访谈邀请，对我们的诊疗方案编写提出宝贵意见。访谈专家：丁书文、薛一涛、李晓鲁、崔向宁。访谈提纲包括应用范围、证候类型、中西医结合干预和推荐方案（分药物干预方案和非药物干预方案）以及中西医结合策略。

（2）受访专家名单

建议表格的形式列出，见表2。

表 2 专家访谈受访专家名单

姓名	单位	职务/职称	专业
丁书文	山东中医药大学附属医院	全国名中医 主任医师	中医心病
薛一涛	山东中医药大学附属医院	主任医师	中医心病
李晓鲁	山东省千佛山医院	主任医师	急诊医学
崔向宁	中国中医科学院广安门医院	主任医师	中西医结合心病

（3）访谈提纲

访谈提纲包括应用范围、证候类型、中西医结合干预和推荐方案（分药物干预方案和非药物干预方案）以及中西医结合策略。

（4）访谈结论

①应用范围：诊断为 2 级原发性高血压的患者均适用；

②证候类型：肝郁气滞证、肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证可基本涵盖患者；

③中医药干预和推荐方案：药物干预和非药物干预；

3.1 药物干预方案：化药、中药汤剂、中成药等；

3.2 非药物干预方案：针刺、推拿、传统功法、中药足浴、耳穴压豆等中医适宜技术；

④中西医结合策略：强化管控患者血压的达标情况，中药西药共同应用优化患者降压方案，应用非药物疗法补充降压措施。

2.临床调研

（1）调研方案确定的过程及方法

应用问卷星开展两轮《2级高血压中西医结合诊疗指南》，调研对象以临床医生为主。第一轮问卷5月24日开始，主要针对《2级高血压中西医结合诊疗指南》所涉及到的基础问题和临床问题，包括适用人群、证候、干预措施（包括具体中药汤剂和中成药）等。共发放问卷100份，收回96份，其中有效问卷96份，有效率96%。

第二轮问卷6月27日开始，主要针对临床医生对关注问题重要性的评价，根据第一轮调研问卷、诊疗方案草案大纲以及专家访谈，共总结归纳30个问题进入第二轮调查。共发放问卷51份，收回51份，其中有效问卷51份，有效率100%。汇总分析专家访谈与临床调研结果，形成23个标准问题的初步清单。

（2）调研对象分布情况

调查对象包括主治医师23人，副主任医师30人，主任医师43人。调查对象来自山东、北京、辽宁、江苏、上海、四川、吉林、湖北、天津、新疆、福建、湖南、重庆、河南、内蒙古、浙江、广东、山西。

（3）调研结论

详见附件2。

3.指南问题原始清单，见表3。

表 3 指南原始问题清单

序号	问题
1	2 级高血压患者的常见证候类型可以归结为肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证吗？
2	天麻钩藤饮适宜干预 2 级高血压肝火亢逆证患者吗？
3	镇肝熄风汤适宜干预 2 级高血压阴虚阳亢证患者吗？
4	半夏白术天麻汤适宜干预 2 级高血压痰湿壅盛证患者吗？
5	血府逐瘀汤合涤痰汤适宜干预 2 级高血压痰瘀互结证患者吗？
6	六味地黄丸或知柏地黄丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者吗？
7	肾气丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阳虚）患者吗？
8	中成药（松龄血脉康、珍菊降压片、牛黄降压丸）适宜干预 2 级高血压患者吗？

9	针刺治疗能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？
10	推拿能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？
11	耳穴贴压能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？
12	中药足浴能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？
13	传统运动方式（太极拳、八段锦、五禽戏）能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？
14	耳尖放血能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？
15	首诊诊为 2 级高血压的患者，可否运用中医养生调摄来增强生活方式指导对血压的疗效？
16	首诊诊为 2 级高血压的患者，可否运用中医药疗法协助控制血压？
17	对于中医疗法意愿强烈的诊为 2 级高血压首诊患者，如何控制患者血压？
18	对于化药控制后血压达标但仍存在症状的 2 级高血压患者，可否运用中医药疗法改善患者症状？
19	对于化药控制后存在副作用的 2 级高血压患者，如何采用中药提高疗效？
20	在改善生活方式的基础上，应用多种降压药物，治疗后血压达标且有减药需求的2级高血压患者如何控制患者血压？
21	在改善生活方式的基础上,血压仍高于 160/100mmHg 的 2 级高血压患者如何控制患者血压？
22	在改善生活方式的基础上，应用一类降压药物，血压仍高于 160/100mmHg 的 2级高血压患者如何控制患者血压？
23	在改善生活方式的基础上，应用 2 类或 2 类以上降压药物，血压仍高于 160/100mmHg 的 2 级高血压患者如何控制患者血压？

4.指南问题

（1）指南问题形成方法

确定临床问题：结合诊疗方案前期基础开展临床问题问卷调查，初步形成临床问题清单，于 2022年7月2日召开《2级高血压中西医结合诊疗指南》“临床问题确定会”，经过专家投票、讨论，最终形成13个临床问题。

证据收集与质量评价：2022年7月4日，李运伦教授在山东中医药大学附属医

院召开“2级高血压中西医结合诊疗指南”项目系统评价方法讨论会，确定采用GRADE 方法学。根据问题清单，诊疗方案工作组构建 PICOS 问题，再由 PICOS 问题制定检索策略与文献纳入排除标准，并在中英文数据库进行检索，经人工筛查后，进行系统综述/META 分析。诊疗方案工作组根据 GRADE 系统进行证据等级评价，形成结果总结表与证据概要表。

共识推荐意见形成：2022年7月25日至8月8日采用改良德尔菲法法对证据形成推荐意见。本共识主要起草人、临床专家组、方法学组中来自全国的26位专家参与了投票。最终，由共识秘书处统计并汇总推荐意见及强度，对临床问题进行推荐。

（2）指南问题清单

建议以表格形式列出最终的指南问题清单。见表4。

表 4 指南问题清单

序号	问题
1	2 级高血压患者的常见证候类型可以归结为肝郁气滞证、肝火亢逆证、阴 虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证吗？
2	2 级高血压患者，在接受生活方式干预的基础上，可联用中医养生调摄等 方法以协助降压？
3	2 级高血压患者，可否联用中医药疗法协助控制血压？
4	2 级高血压患者，存在头晕、头痛等不适症状，在常规西医治疗基础上， 可否联用中医药疗法缓解患者不适症状？
5	2 级高血压患者血压波动大者，是否适宜常规西药联合中医药疗法协助降 压？
6	对于 2 级高血压（高危）患者，是否联用中医药疗法协助防治靶器官损伤 （心、脑、肾）？
7	对于伴冠心病、糖尿病、心衰、肾功能不全、高脂血症等疾病的 2 级高血 压（很高危）患者，是否联用中医药疗法协助降压？
8	2 级单纯收缩期高血压患者是否适宜联合中医药疗法协助降压？
9	对于中医药疗法意愿强烈的 2 级高血压患者，可否联用中医药疗法以协助 控制血压？
10	对于 2 级高血压患者，与常规治疗相比，联合中医药对协助减/撤西药有 何帮助？
11	中成药适宜干预 2 级高血压患者吗？
12	中医经典方剂（柴胡疏肝散、天麻钩藤饮、镇肝熄风汤、半夏白术天麻汤、 血府逐瘀汤合涤痰汤、六味地黄丸、肾气丸）适宜干预 2 级高血压患者吗？

13	中医适宜技术（针刺、耳穴贴压、足浴、太极拳）适宜干预 2 级高血压患者吗？

（五）证据的检索、筛选、提取与综合

1.证据检索

（1）检索方法

1、文献来源：

检索数据库：CNKI、维普、万方、Pubmed、EMBASE、Cochrance Library

在研检索：http://www.chictr.org.cn

https://www.isrctn.com/

https://clinicaltrials.gov/

https://apps.who.int/trialsearch/

https://www.clinicaltrialsregister.eu/

其它检索：互联网上查找相关的文献（百度、谷歌），同时追查已纳入文献的参考文献

2、检索式

检索词分疾病和中医干预措施两大部分，检索采用主题词与自由词（同义词和近义词）相结合的方式，根据数据库的检索系统进行具体调整。以临床问题：2级高血压中合并靶器官损伤（心、脑、肾）等患者如何用中药防治为例，详见如下：

①中文数据库检索式

知网检索式：SU %= '中医药'+'中药'+'中医'+'中医疗法' AND SU %= '靶器官损害'+'心'+'脑'+'肾'+'眼'+'损害' AND SU %= '2级高血压'+'高血压'+'高血压病'+'眩晕'+'头晕'+'头痛' AND SU %= '临床研究' + '临床观察'+'随机对照研究'

维普检索式：R=(2级高血压 OR 高血压 OR 眩晕 OR 头晕 OR 头痛 OR 高血压病 OR) AND R=(中医药 OR 中药 OR 中医 OR 中医疗法) AND R=(靶器官损害) AND R=(临床研究 OR 临床观察 OR 随机对照研究)

万方检索式：(题名或关键词:("2级高血压") or 题名或关键:("高血压")or 题名或关键词:("眩晕")or 题名或关键词:("头晕")or 题名或关键词:("头痛")or 题名或关键词:("高血压病")) and （题名或关键词:("中医药") or 题名或关键词:("中药")or 题名或关键词:("中医")or 题名或关键词:("中医疗法")）

and （题名或关键词:("靶器官损害") or 题名或关键词:("心")or 题名或关键词:("脑")or 题名或关键词:("肾")or 题名或关键词:("眼") or题名或关键词:("损害")）and （题名或关键词:("临床研究") or 题名或关键词:("临床观察")or 题名或关键词:("随机对照研究")）

②英文数据库检索式

Pubmed ： ("Hypertension"[Mesh] OR dizzy[Title/Abstract] OR headache[Title/Abstract] OR Hypertension Grade 2 [Title/Abstract] OR vertigo[Title/Abstract]) AND (Traditional Chinese medicine[Title/Abstract] OR TCM[Title/Abstract] OR Traditional Chinese Medicine therapy [Title/Abstract]) AND (target organ damage[Title/Abstract] OR cardiac[Title/Abstract] OR brain [Title/Abstract]OR kidney [Title/Abstract] OR eye [Title/Abstract]OR damage [Title/Abstract])AND (clinical study[Title/Abstract] OR RCT[Title/Abstract])

（2）检索结果

根据检索策略检索出相关文献共2935篇，包括中文数据库2874篇，英文数据库61篇，其中中国知网1275篇，维普973篇，万方626篇，Pubmed14篇，The Cochrane Library27篇，Embase20篇。

2.证据筛选和资料提取

（1）证据筛选和资料提取方法

对于检索到的结果由两位以上检索者进行初筛，初筛后阅读文章全文并进一步筛选，对于有争议的结果由组内专家进行讨论后是否纳入。

资料提取文章，作者，发表年度，样本量，结局指标等内容，运用EndNote及Excel构建文献提取表收集相关资料。

（2）纳入排除标准

纳入标准：受试者：纳入的患者为原发性高血压患者，无论诊断标准根据哪一版本的指南、共识或者教科书。病人民族、年龄、性别、病例来源不限。

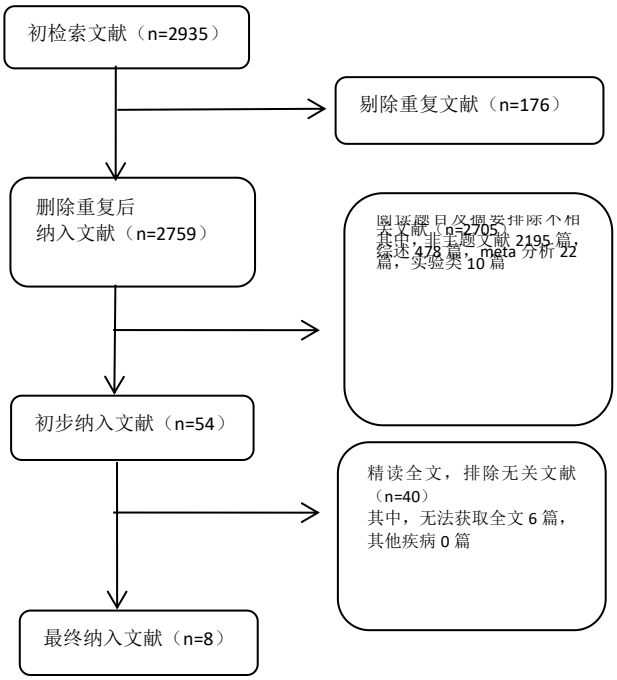
结局指标:①病死率；②心血管事件发生率；③降低病死率；④降低心血管事件发生率；⑤中医证候相关症状体征；⑥血压水平，包括收缩压及舒张压、动态血压等；⑩不良反应发生率等。

排除标准：受试者：继发性高血压患者。

说明：具体纳排标准根据临床问题的不同而有差异。

（3）证据筛选流程及结果

以2级高血压中合并靶器官损伤（心、脑、肾）等患者如何用中药防治为例，证据筛选流程图见图1，详细如下：



3.证据综合

本共识采用荟萃分析的方式综合证据，后采用GRADE方法评价证据质量。对于证据不足以进行荟萃分析的，采用GRADE方法评价证据质量。

（六）证据分级

1.证据分级方法

本次研究中采用采用 GRADE 方法对证据分级进行评价。GRADE 系统将证据质量分为高、中、低和极低 4 级。最终形成结果总结表与证据概要表。

2.证据概要表

本共识主要起草人、临床专家组、方法学组中来自全国的 26 位专家参与了共识会议，共识会议由三部分组成，首先由李运伦教授向与会者介绍该共识的背景、立项到完成 GRADE 分级的全过程，其次由秘书滑振介绍该共识的方法学以及证据概要，最后由中华中医药学会苏祥飞主任主持共识会的投票过程。

问题1：2级高血压患者的常见证候类型可以归结为肝郁气滞证、肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证吗？

基础问题	2 级高血压患者的常见证候类型可以归结为肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证、肝郁气滞证吗？
研究类型及数量	共检索 144 篇文献 流行病学调查 141 篇 专家共识 3 篇
统计分析结果	结果显示，共检索 144 篇文献，其中流行病学调查 141 篇，专家共识 3 篇，结果显示：肝郁气滞证：20 篇，肝火亢逆证：57 篇，阴虚阳亢证：71 篇，痰湿壅盛证：48 篇，痰瘀互结证：36 篇，阴阳两虚证：37 篇。
结论	2 级高血压患者的常见证候类型可以归结为肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证、肝郁气滞证

符号	↑	/	↓
详细描述	建议	中立	不建议
共识条目：	2 级高血压患者的常见证候类型可以归结为肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证、肝郁气滞证等 建议□　中立□　不建议□		
①疗效	共检索 144 篇文献，其中流行病学调查 141 篇，专家共识 3 篇，结果显示：肝郁气滞证：20 篇，肝火亢逆证：57 篇，阴虚阳亢证：71 篇，痰湿壅盛证：48 篇，痰瘀互结证：36 篇，阴阳两虚证：37 篇。高血压中医诊疗专家共识（2018）提出在证候特点上，高血压包括肝阳上亢、痰饮内停、肾阴亏虚 3 大证型，高血压中医诊疗专家共识（2019）提出肝阳上亢、痰饮内停、肾阴亏虚，高血压中医诊疗指南（2011）提出肝火上炎、痰湿内阻、瘀血内阻、阴虚阳亢等证型。		
②安全性	--		
③经济性	--		
④病人可接受度	--		
⑤其他因素	--		

问题 2： 2 级高血压患者，在接受生活方式干预的基础上，可联用中医养生调摄等方法以协助降压？

质量评价	结果总结

研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 21 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1109	1041	MD=-10.61，95% CI [-12.72,-8.50]	中
舒张压 21 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1109	1041	MD=-7.65,95%CI [-9.15,-6.15]	中
临床疗效 5 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	264	264	RR=1.23，95%CI [1.13，1.34]	中
证候积分 5 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	236	236	MD=-0.87,95%CI [-0.41,-2.15]	中
血压达标率 6 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	396	346	RR=1.24，95%CI [1.07，1.43]	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
2 级高血压患者，可否在生活方式干预的基础上联用中医养生调摄等方法来协助降压？	高血压患者	中医养生调摄增强生活方式指导	常规治疗（常规护理，健康管理，常规社区管理，非药物疗法干预等）	总有效率、收缩压、舒张压、证候积分、血压达标率
研究类型及数量	28 个 RCT			

效应值及可信区间	收缩压：MD=-10.61，95% CI [-12.72,-8.50] 舒张压：MD=-7.65，95% CI [-9.15,-6.15] 临床疗效：RR=1.23，95% CI [1.13，1.34] 证候积分：MD=-0.87，95% CI [-0.41,-2.15] 血压达标率：RR=1.24，95% CI [1.07，1.43]
证据等级	B 级
是否升级或降级	降一级
升级或降级因素	不一致性
结论	2 级高血压患者，可在生活方式干预的基础上联用中医养生调摄等方法来协助降压

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	2 级高血压患者，可在生活方式干预的基础上联用中医养生调摄等方法来协助降压 推荐意见：				
①证据等级	B 级				
②疗效	28 篇 RCT 的 meta 分析结果显示，肾气丸单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-10.61，95% CI [-12.72,-8.50]，舒张压：MD=-7.65，95% CI [-9.15,-6.15]，临床疗效：RR=1.23，95% CI [1.13，1.34]，证候积分：MD=-0.87，95% CI [-0.41,-2.15]，血压达标率：RR=1.24，95% CI [1.07，1.43]。				
③安全性	纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 3： 2 级高血压患者（中危）可否联用中医药疗法协助控制血压？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 4 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	130	132	MD=-8.50，95% CI [-10.10,-6.90]	中

舒张压 4 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	130	132	MD=-5.04，95% CI [-7.75,-2.34]	极低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
2 级高血压患者（中危）可否运用中医药疗法协助控制血压？	2 级高血压患者	中医药+西药	常规治疗（西药）	收缩压、舒张压
研究类型及数量	4 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-8.50，95% CI [-10.10,-6.90] 舒张压：MD=-5.04，95% CI [-7.75,-2.34]			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	2 级高血压患者（中危）可运用中医药疗法协助控制血压			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	2 级高血压患者（中危）可运用中医药疗法协助控制血压 推荐意见：				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 4 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中医药疗法单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-8.50，95% CI [-10.10,-6.90] 舒张压：MD=-5.04，95% CI [-7.75,-2.34]。				
③安全性	应用针刺后有 5 例患者针刺部位酸胀疼痛显著，2 例患者出现局部小血肿，经局部按压后血肿消失。应用穴位贴敷后皮肤灼热感者 6 人，痒感者 5 人，混合感觉者 14 人，刺痛感者 3 人，局部皮肤无变化者 1 人，出现潮红者 3 人，轻微红肿者 19 人，小水疱者 8 人。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	各 RCT 干预措施为：针刺加硝苯地平：硝苯地平，穴位贴敷治疗+硝苯地平：硝苯地平，耳穴贴压+贝那普利、硝苯地平：贝那普利、硝苯地平，经验方 +左氨氯地平：左氨氯地平。				

问题 4： 对于存在症状的 2 级高血压患者（中危），可否运用中医药疗法改善患者症状？

质量评价	结果总结

研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 2个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	60	62	MD=-8.59，95% CI [-10.85,-6.33]	中
舒张压 2个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	60	62	MD=-5.52，95% CI [-7.89，-3.14]	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O结局指标
对于存在症状的2级高血压患者（中危），可否运用中医药疗法改善患者症状？	2级高血压患者	中医药+西药	常规治疗（西药）	收缩压、舒张压
研究类型及数量	2个RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-8.59，95% CI [-10.85,-6.33] 舒张压：MD=-5.52，95% CI [-7.89，-3.14]			
证据等级	B级			
是否升级或降级	降一级			
升级或降级因素	局限性			
结论	存在症状的2级高血压患者（中危），可运用中医药疗法改善患者症状			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	存在症状的2级高血压患者（中危），可运用中医药疗法改善患者症状 推荐意见：				
①证据等级	B级				
②疗效	一项纳入2篇RCT的META分析结果显示，中医药疗法单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-8.59，95% CI [-10.85,-6.33]，舒张压：MD=-5.52，95% CI [-7.89，-3.14]。				
③安全性	各RCT干预措施为：针刺+硝苯地平：硝苯地平，穴位贴敷治疗+硝苯地平：硝苯地平，经验方+左氨氯地平：左氨氯地平。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				

⑥其他因素	有 5 例患者针刺部位酸胀疼痛显著，2 例患者出现局部小血肿，经局部按压后血肿消失。穴位贴敷后皮肤灼热感者 6 人，痒感者 5 人，混合感觉者 14 人，刺痛感者 3 人，局部皮肤无变化者 1 人，出现潮红者 3 人，轻微红肿者 19 人，小水疱者 8 人。

问题 5： 2 级高血压患者（中危）西药降压后血压波动大者是否适宜中西医结合干预？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
24hSSD 3 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	80	80	MD=-5.55，95% CI［-9.77，-1.33］	低
24hDSD 3 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	80	80	MD=-3.10，95% CI［-6.49，0.30］	低
临床疗效 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	60	60	OR=1.94，95% CI［0.10，39.58］	极低
SBP 4 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	110	110	MD=-4.50，95% CI［-8.27,-0.73］	低
DBP 4 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	110	110	MD=-0.87，95% CI［-4.78,3.04］	极低

共识问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O（结局指标）
2 级高血压患者(中危）西药降压后血压波动大者是否适宜中西医结合干预？	2 级高血压患者	中药汤剂	常规治疗	24hSSD,24hDSD,有效率,SBP,DBP
研究类型及数量	4 个 RCT			
效应值及可信区间	24hSSD：MD=-5.55，95% CI［-9.77，-1.33］ 24hDSD：MD=-3.10，95% CI［-6.49，0.30］ 有效率：OR=1.94，95% CI［0.10，39.58］ SBP：MD=-4.50，95% CI［-8.27,-0.73］ DBP：MD=-0.87，95% CI［-4.78,3.04］			
证据等级	D 级			
是否升级或降级	降三级			
升级或降级因素	局限性，不一致性，不精确性			

结论	2 级高血压中危患者西药降压后血压波动大者适宜中西医结合干预

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	2 级高血压中危患者西药降压后血压波动大者适宜中西医结合干预 推荐意见：				
①证据等级	D 级				
②疗效	一项纳入 4 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中西医结合干预在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，24hSSD：MD=-5.55，95% CI [-9.77，-1.33]，24hDSD：MD=-3.10，95% CI [-6.49，0.30]，有效率：OR=1.94，95% CI [0.10，39.58]，SBP：MD=-4.50，95% CI [-8.27,-0.73]，DBP：MD=-0.87，95% CI [-4.78,3.04]。				
③安全性	应用石决牡蛎汤加氨氯地平后，试验组与对照组治疗过程中各有一例出现踝部轻度水肿，均能耐受，继续治疗，未见其他不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	各 RCT 干预措施为：石决牡蛎汤+氨氯地平：氨氯地平，复方天麻钩藤颗粒+氨氯地平：氨氯地平，潜阳育阴颗粒+非洛地平、依那普利：非洛地平、依那普利。				

问题 6：2 级高血压患者（中/高危）可否运用中医药疗法协助控制血压？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 4 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	184	183	MD=-9.29，95%CI [-13.23,-13.36]	低
舒张压 4 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	184	183	MD=-7.68，95%CI [-10.17,-5.20]	低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
2 级高血压患者（中/高危）可否运用中医药疗法协助控制血压？	2 级高血压患者	中医药+西药	常规治疗（西药）	收缩压、舒张压
研究类型及数量	4 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-9.29，95% CI [-13.23,-13.36] 舒张压：MD=-7.68，95% CI [-10.17,-5.20]			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			

结论	2 级高血压患者（中/高危）可运用中医药疗法协助控制血压

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	2 级高血压患者（中/高危）可运用中医药疗法协助控制血压 推荐意见：				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 4 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中医药疗法单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-9.29，95% CI [-13.23,-13.36]，舒张压：MD=-7.68，95% CI [-10.17,-5.20]。				
③安全性	未见不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	各 RCT 干预措施为：复方丹参滴丸+替米沙坦：替米沙坦，天麻钩藤颗粒+替米沙坦：替米沙坦，中药汤剂+非洛地平：非洛地平，穴位贴敷+氨氯地平：氨氯地平。				

问题 7： 对于存在症状的 2 级高血压患者（中/高危），可否联用中医药疗法协助改善症状？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	94	93	MD=-10.63，95% CI [-18.68,-2.59]	极低
舒张压 2 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	94	93	MD=-7.53，95% CI [-8.78,-6.27]	中
临床疗效 2 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	94	93	RR=1.36，95% CI [1.12,1.64]	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
对于存在症状的 2 级高血压患者（中/高危），可否运用中医药疗法改善患者症状？	2 级高血压患者	中医药+西药	常规治疗（西药）	收缩压、舒张压
研究类型及数量	2 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-10.63，95% CI [-18.68,-2.59]			

	舒张压：MD=-7.53，95% CI [-8.78,-6.27] 临床疗效：RR=1.36，95% CI [1.12,1.64]
证据等级	C 级
是否升级或降级	降二级
升级或降级因素	局限性　不一致性
结论	存在症状的 2 级高血压患者（中/高危），可运用中医药疗法改善患者症状

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	存在症状的 2 级高血压患者（中/高危），可运用中医药疗法改善患者症状 推荐意见：				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 2 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中医药疗法单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-10.63，95% CI [-18.68,-2.59]，舒张压：MD=-7.53，95% CI [-8.78,-6.27]，临床疗效：RR=1.36，95% CI [1.12,1.64]。				
③安全性	未见不良反应				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	各 RCT 干预措施为：复方丹参滴丸+替米沙坦：替米沙坦，穴位贴敷+氨氯地平：氨氯地平。				

问题 8：2 级高血压患者（中/高危）西药降压后血压波动大者是否适宜中西医结合干预？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
SBP 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	65	65	MD=-10.65，95% CI [-14.08, -7.23]	极低
DBP 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	65	65	MD=-4.69，95% CI [-7.90, -1.49]	极低

共识问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O（结局指标）
2 级高血压患者(中/高危)西药降压后血压波动大者是否适宜中西医结合干预	2 级高血压患者	中医药+西药	常规治疗(西药)	SBP，DBP
研究类型及数量	2 个 RCT			

效应值及可信区间	SBP：MD=-10.65，95% CI [-14.08，-7.23] DBP：MD=-4.69，95% CI [-7.90，-1.49]
证据等级	D 级
是否升级或降级	降三级
升级或降级因素	局限性，不一致性，不精确性
结论	2 级高血压中/高危患者西药降压后血压波动大者适宜中西医结合干预

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	2 级高血压中/高危患者西药降压后血压波动大者适宜中西医结合干预 推荐意见：				
①证据等级	D 级				
②疗效	一项纳入 2 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中西医结合干预在收缩压、舒张压等方面均优于单独应用常规西药治疗，SBP：MD=-10.65，95% CI [-14.08，-7.23]， DBP：MD=-4.69，95% CI [-7.90，-1.49]。				
③安全性	未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 9： 2 级高血压患者（高危）可否联用中医药疗法协助控制血压？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 3 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	112	112	MD=-12.30，95% CI [-23.46，-1.14]	极低
舒张压 3 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	112	112	MD=-12. 77，95% CI [-21.15,-4.39]	低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
2 级高血压患者（高危）可否运用中医药疗法协助控制血压？	2 级高血压患者	中医药疗法+西药	常规治疗（西药）	收缩压、舒张压
研究类型及数量	3 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-12.30，95% CI [-23.46，-1.14] 舒张压：MD=-12. 77，95% CI [-21.15,-4.39]			

证据等级	C 级
是否升级或降级	降二级
升级或降级因素	局限性，不一致性
结论	2 级高血压患者（高危）可运用中医药疗法协助控制血压

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	2 级高血压患者（高危）可运用中医药疗法协助控制血压 推荐意见：				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 3 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中医药疗法单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-12.30，95% CI [-23.46，-1.14]，舒张压：MD=-12. 77，95% CI [-21.15,-4.39]。				
③安全性	未报道不良反应				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 10： 2 级高血压（高危）患者，存在头晕、头痛等不适症状，在常规西医治疗基础上，可否联用中医药疗法缓解患者不适症状？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	82	82	MD=-12.3，95% CI [-23.46，-1.14]	低
舒张压 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	82	82	MD=-8.84，95% CI[-17.6，-0.08]	低
临床疗效 2 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	82	82	MD=-3.26，95% CI [-3.33，-3.19]	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
对于存在症状的 2 级高血压患者（高危），可否联用中医药疗法协助改善症状？	2 级高血压患者	中医药+西药	常规治疗（西药）	收缩压、舒张压
研究类型及数量	2 个 RCT			

效应值及可信区间	收缩压：MD=-12.3，95% CI [-23.46，-1.14] 舒张压：MD=-8.84，95% CI[-17.6，-0.08] 临床疗效：MD=-3.26，95% CI [-3.33，-3.19]
证据等级	C 级
是否升级或降级	降二级
升级或降级因素	局限性，不一致性
结论	存在症状的 2 级高血压患者（高危），可联用中医药疗法协助改善症状

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	存在症状的 2 级高血压患者（高危），可联用中医药疗法协助改善症状 推荐意见：				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 2 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中医药疗法单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-12.3，95% CI [-23.46，-1.14]，舒张压：MD=-8.84，95% CI[-17.6，-0.08]，临床疗效：MD=-3.26，95% CI [-3.33，-3.19]。				
③安全性	未见不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 11：对于 2 级高血压（高危）患者，是否联用中医药疗法协助防治靶器官损伤（心、脑、肾）？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 9 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	646	632	MD=0.98，95% CI [-0.68，2.63]	中
舒张压 9 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	646	632	MD=0.58，95% CI [-0.85，2.01]	极低
症状改善率 3 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	121	113	OR = 3. 83，95% CI [1.81,8.11]	中
LVDd 10 个 RCT	严重局	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确	存在	695	678	MD=0.47 ， 95% CI [-1.36 ， 2.30]	低

	限			性					
IVST 10 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	695	668	MD=-0.26，95% CI［-0.52，0.01］	低
LVPWT 10 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	695	678	MD=-0.22，95% CI［-0.45，0.00］	低
LVMI 10 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	425	404	MD=-1.97，95% CI［-4.24，0.30］	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
对于 2 级高血压(高危）患者，是否联用中医药疗法协助防治靶器官损伤（心、脑、肾）？	2 级高血压患者	珍珠降压片，牛膝降压丸，益脉降压流浸膏，心肌康，山绿茶降压片，调压益心胶囊，黄连清降合剂，降压舒心胶囊，松龄血脉康，天丹降压颗粒剂，降压舒心丸	卡托普利，美托洛尔，吲达帕胺	LVH 指标，血压，症状
研究类型及数量	11 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=0.98，95% CI［-0.68，2.63］ 舒张压：MD=0.58，95% CI［-0.85，2.01］ LVDd：MD=0.47，95% CI［-1.36，2.30］ IVST：MD=-0.26，95% CI［-0.52，0.01］ LVPWT：MD=-0.22，95% CI［-0.45，0.00］ LVMI：MD=-1.97，95% CI［-4.24，0.30］			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	2 级高血压患者中合并靶器官损伤（心、脑、肾）等危险因素患者可用中药防治			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	2 级高血压患者中合并靶器官损伤（心、脑、肾）等危险因素患者可用中药防治 推荐意见：				
①证据等级					
②疗效	一项纳入 11 篇 RCT 的 META 分析结果显示，单用中成药与单用西药比较，干预逆转 LVH 及降压疗效无明显差异，而在改善临床症状方面，中成药体现出优势，不良反应方面，中成药组的不良反应主要是胃肠道反应，而对照组的不良反应主要集中在咳嗽，与对照药(血管紧张素转化酶抑制剂）的				

	选择有关，但出现的不良反应都较轻微。
③安全性	治疗组 2 例出现低钾血症，2 例出现轻微胃部不适，1 例出现便溏。对照组 12 例出现干咳，1 例出现血肌酐一过性升高，2 例出现乏力， 1 例出现头晕， 1 例出现皮肤瘙痒。其它文献文件不良反应报道。
④经济性	--
⑤病人可接受度	--
⑥其他因素	--

问题 12： 2 级高血压患者（很高危）可否联用中医药疗法协助控制血压？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 3 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	96	92	MD=-4.6，95% CI [-6.65，-2.55]	低
舒张压 3 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	96	92	MD=-2.25，95% CI [-4.06，-0.44]	低
临床疗效 2 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	82	82	MD=-3.26，95% CI [-3.33,-3.19]	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
2 级高血压患者(很高危）可否运用中医药疗法协助控制血压？	2 级高血压患者	中医药+西药	常规治疗（西药）	收缩压、舒张压
研究类型及数量	3 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-4.6，95% CI [-6.65，-2.55] 舒张压：MD=-2.25，95% CI [-4.06，-0.44] 临床疗效：MD=-3.26，95% CI [-3.33,-3.19]			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	2 级高血压患者（很高危）可运用中医药疗法协助控制血压			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	2 级高血压患者（很高危）可运用中医药疗法协助控制血压 推荐意见：				

①证据等级	C 级
②疗效	一项纳入 3 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中医药疗法单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-4.6，95% CI [-6.65，-2.55]，舒张压：MD=-2.25，95% CI [-4.06，-0.44]，临床疗效：MD=-3.26，95% CI [-3.33,-3.19]。
③安全性	未见不良反应
④经济性	对照组有 2 例患者出现轻度头痛、水肿、干咳等不良反应。
⑤病人可接受度	--
⑥其他因素	各 RCT 干预措施为：半夏白术天麻汤+硝苯地平、缬沙坦：硝苯地平、缬沙坦，解毒通络调肝降压方+二甲双胍、缬沙坦、氨氯地平：二甲双胍、缬沙坦、氨氯地平，潜阳育阴颗粒+阿托伐他汀，氨氯地平：阿托伐他汀，氨氯地平。

问题 13： 对于存在症状的 2 级高血压患者（很高危），可否运用中医药疗法改善患者症状？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 2 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	64	64	MD=-4.81，95% CI [-7.03，-2.60]	中
舒张压 2 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	64	64	MD=-2.66，95% CI [-4.7，-0.62]	中
临床疗效 2 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	64	64	MD=-5.98，95% CI [-8.38，-3.57]	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
对于存在症状的 2 级高血压患者（很高危），可否运用中医药疗法改善患者症状？	2 级高血压患者	中医药+西药	常规治疗（西药）	收缩压、舒张压
研究类型及数量	2 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-4.81，95% CI [-7.03，-2.60] 舒张压：MD=-2.66，95% CI[-4.7，-0.62] 临床疗效：MD=-5.98，95% CI [-8.38，-3.57]			
证据等级	B 级			
是否升级或降级	降一级			
升级或降级因素	局限性			
结论	存在症状的 2 级高血压患者（很高危），可运用中医药疗法改善患者症状			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	存在症状的 2 级高血压患者（很高危），可运用中医药疗法改善患者症状 推荐意见：				
①证据等级	B 级				
②疗效	一篇纳入 2 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中医药疗法单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-4.81，95% CI [-7.03，-2.60]，舒张压：MD=-2.66，95% CI[-4.7，-0.62]，临床疗效：MD=-5.98，95% CI [-8.38，-3.57]。				
③安全性	未见不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	各 RCT 干预措施为：半夏白术天麻汤+硝苯地平、缬沙坦：硝苯地平、缬沙坦，解毒通络调肝降压方+二甲双胍、缬沙坦、氨氯地平：二甲双胍、缬沙坦、氨氯地平。				

问题 14：对于伴冠心病、糖尿病、心衰、肾功能不全、高脂血症等疾病的 2 级高血压（很高危）患者，是否联用中医疗法协助降压？

基础问题	伴冠心病、糖尿病、心衰、肾功能不全，高脂血症等疾病的 2 级高血压患者，中医药如何参与？
研究类型及数量	共检索 13 篇文献 RCT13 篇
统计分析结果	结果显示，对于合并高脂血症的患者，应用灵芝调脂茶联合苯磺酸氨氯地平，阿托伐他汀对比苯磺酸氨氯地平联合阿托伐他汀，治疗后的组间对比，治疗组对比对照组，甘油三酯（t=-8.178,p<0.0001）、胆固醇（t=-4.95，p<0.0001）、低密度脂蛋白（t=-5.81,p<0.0001），差异均具有统计学意义。治疗组降脂疗效优于对照组，说明灵芝调脂茶联合西药在降低血脂各项水平上均有很好疗效。收缩压（t=3.18,p=0.0024）、舒张压（t=4.34,p<0.0001），差异有统计学意义，说明灵芝调脂茶联合西药在对降血压的疗效上有明显差异，治疗组疗效优于对照组。 对于合并 2 型糖尿病的患者,应用解毒通络调肝降压方联合二甲双胍片，氯沙坦，氨氯地平对比二甲双胍片，氯沙坦，氨氯地平。两组治疗后中医症候改善有效率 93.33%，86.67%（P＜0.05），治疗后中医证候积分 9.80±5.76,14.07±6.55(P＜0.05),两组经治疗后 FPG 为 6.75±0.66，7.12±0.62（P＜0.05）、2h PG 为 9.64±1.53，10.37±1.26（P＜0.05）、Hb A1c 为 6.77±0.84，7.27±0.64（P＜0.05），两组血糖疗效总有效率 86.67%，70.00%（P＜0.05），治疗前后 SBP130.67±6.61，134.13±5.42 mmHg（P＜0.05），DBP86.97±6.03，90.10±5.54（P＜0.05），降压有效率 93.33%，76.67%（P＜0.05），治疗后胰岛素抵抗指数 2.24±0.71，2.69±0.82（P＜0.05）。 对于合并冠心病的患者，应用中药汤剂联合常规药物治疗对比常规药物治疗，在控制血压、缓解冠心病症状、改善心功能个上均有更好的疗效。两组治疗后临床症状改善有效率分别为 89.47%和 73.68%（*P*=0.000），治疗后收缩压分别为 128.78±9.83mmHg 和 136.45±9.14mmHg（*P*=0.000),治疗后舒张压分别为85.73±4.36mmHg和90.03±5.59mmHg（*P*=0.000),治疗后MAP分别为100.22±4.73mmHg和105.15±5.11mmHg（*P*=0.000),治疗后心绞痛发作次数分别为 0.89±0.25 次/每周和 1.47±0.36 次/每周(*P*=0.000)，治疗后心绞痛持续时间分别为 3.68±

	1.32min 和 4.35±1.63min(*P*=0.018），治疗后硝酸甘油使用量 0.43±0.28mg/周和 0.86±0.26mg/周(*P*=0.001)，治疗后 CI 分别为 4.12±0.77L/(min•m^2)和 3.67±0.68L/(min•m^2)（*P*=0.001），治疗后 CO 分别为 4.88±0.49L/min 和 4.26±0.53L/min(*P*=0.000)，治疗后 EF 分别为 53.51±9.57%和 48.86±9.32%(*P*=0.010)，治疗后 LVEDD 分别为 4.01±0.56cm 和 4.88±0.49cm(*P*=0.000），治疗后 MDA 分别为 8.57±2.18mmol/L 和 10.02±1.97mmol/L(*P*=0.000)，治疗后 SOD 分别为 69.46±7.56U/L 和 63.37±7.62U/L(*P*=0.000)，治疗后 NO 分别为 44.86±5.32mmol/L 和 38.51±4.57mmol/L(*P*=0.000)。
结论	2 级高血压（很高危）患者中伴发糖尿病者，在常规药物治疗的基础上，辨证联用中药汤剂/中成药/中医适宜技术（耳穴贴压、针刺），以协助控制血压水平。

符号	↑	/	↓
详细描述	建议	中立	不建议
共识条目：	伴冠心病、糖尿病、心衰、肾功能不全，高脂血症等疾病的 2 级高血压患者，可应用各类疗方法参与 建议☐　中立☐　不建议☐		
①疗效	灵芝调脂茶联合西药可降低血脂各项水平，降低血压，治疗组疗效优于对照组。 解毒通络调肝降压方联合联合西药能有效降低空腹胰岛素水平，有效改善胰岛素抵抗程度压达标率，降低血糖，改善中医症候。		
②安全性	未见不良反应相关报道		
③经济性	--		
④病人可接受度	--		
⑤其他因素	--		

问题 15：2 级单纯收缩期高血压患者是否适宜联合中医药疗法协助降压？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 3 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	272	257	MD=-6.86，95% CI [-11.76,-1.96]	低
临床疗效 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	214	122	RR=1.84，95%CI [1.42，2.38]	低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
2 级高血压中的单纯收缩期高血压患者是否适宜中西医结合干预？	2 级高血压中单纯收缩期高血压患者	中医药疗法或中医药疗法联合降压药物	安慰剂或常规治疗（马来酸依那普利，非药物治疗联合降压方案，）	收缩压、舒张压、临床疗效

研究类型及数量	3 个 RCT
效应值及可信区间	收缩压：MD=-6.86，95% CI [-11.76,-1.96] 临床疗效：RR=1.84，95% CI [1.42，2.38]
证据等级	C 级
是否升级或降级	降二级
升级或降级因素	局限性，不一致性
结论	2 级高血压中的单纯收缩期高血压患者适宜中西医结合干预

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	2 级高血压中的单纯收缩期高血压患者适宜中西医结合干预 推荐意见：				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 3 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中医药疗法+降压药物单独应用或联合常规西药在收缩压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-6.86，95% CI [-11.76,-1.96]，临床疗效：RR=1.84，95% CI [1.42，2.38]。				
③安全性	1 篇文献报告了治疗组、对照组均出现 1 例不良反应，但未详细描述，除上述文献外其他纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 16：对于中医疗法意愿强烈的 2 级高血压患者，可否联用中医药疗法以协助控制血压？

基础问题	对于中医疗法意愿强烈的 2 级高血压患者，可否联用中医药疗法以协助控制血压？
研究类型及数量	共检索 1 篇文献 RCT1 篇
统计分析结果	临床研究发现高血压病患者治疗时应以痰瘀同治、解毒通络为大法，依据病因，合理遣方用药，可明显提高降压效果，改善患者症状，停、减降压西药用量，改善患者情绪，调节心肝肾及神经系统功能，从微观及宏观两方面调节机体功能状态。
结论	结果显示，对于中医疗法意愿强烈的诊为 2 级高血压患者，可联用中医药疗法协助控制血压

符号	↑	/	↓
详细描述	建议	中立	不建议
共识条目：	对于中医疗法意愿强烈的诊为 2 级高血压患者，可联用中医药疗法协助控制血压 建议□　中立□　不建议□		
①疗效	入组时患者 2 级高血压患者 30 例，占 20.55%。第 1 疗程后 2 级高血压病降压的总有效率为 第 2 疗程后 2 级高血压病降压的总有效率为 16.80%。 随着疗程的延长，2 级的高血压病疗		
②安全性	临床观察患者未报道不良反应		

③经济性	--
④病人可接受度	--
⑤其他因素	--

问题 17：对于 2 级高血压患者，与常规治疗相比，联合中医药对协助减/撤西药有何帮助？

基础问题	对于 2 级高血压患者，与常规治疗相比，联合中医药对协助减/撤西药有何帮助？
研究类型及数量	共检索 1 篇文献 RCT1 篇
统计分析结果	临床研究发现高血压病患者治疗时应以痰瘀同治、解毒通络为大法，依据病因，合理遣方用药，可明显提高降压效果，改善患者症状，停、减降压西药用量，改善患者情绪，调节心肝肾及神经系统功能，从微观及宏观两方面调节机体功能状态。
结论	结果显示，在改善生活方式的基础上，应用多种降压药物，治疗后血压达标且有减药需求的 2 级高血压患者，可联用中医药疗法协助控制血压

符号	↑	/	↓
详细描述	建议	中立	不建议
共识条目：	在改善生活方式的基础上，应用多种降压药物，治疗后血压达标且有减药需求的 2 级高血压患者，可联用中医药疗法协助控制血压 建议☐　中立☐　不建议☐		
①疗效	入组时患者 2 级高血压患者 30 例，占 20.55%。 第 1 疗程后 2 级高血压病降压的总有效率为 13.20%，第 2 疗程后 2 级高血压病降压的总有效率为 16.80%。 随着疗程的延长，2 级的高血压病疗效增加。		
②安全性	临床观察患者未报道不良反应		
③经济性	--		
④病人可接受度	--		
⑤其他因素	--		

问题 18：柴胡疏肝散适宜干预 2 级高血压肝郁气滞证患者吗？

基础问题	柴胡疏肝散适宜干预 2 级高血压肝郁气滞证患者吗？
研究类型及数量	共检索 1 篇文献 RCT1 篇
统计分析结果	将原发性高血压患者 60 例研究对象随机分为对照组和治疗组各 30 例，两组采用相同的基础治疗降压方案:琥珀酸美托洛尔。治疗组在基础治疗上加入柴胡疏肝散 200ml/次，bid。 治疗组的总有效率为 93.33%，对照组的总有效率为 86.67%。治疗组其疗效与对照组相比，具有显著性差异（P<0.05）。治疗组和对照组

	的血压都下降，具有显著性差异（P<0.05）。治疗组的血压疗效与对照组相比，具有显著性差异（P<0.05）。治疗后两组患者临床症状及体征改善较治疗前均有显著性差异（P<005）。
结论	结果显示，中药柴胡疏肝散加减和琥珀酸美托洛尔缓释片的中西医结合的方法治疗肝气郁结证高血压疗效显著。

符号	↑	/	↓
详细描述	建议	中立	不建议
共识条目：	柴胡疏肝散适宜干预2级高血压肝郁气滞证患者吗？ 建议□　中立□　不建议□		
①疗效	运用柴胡疏肝散加减治疗原发性高血压肝气郁滞证患者，可以改善患者临床症状和体征，控制血压，可降低血液粘稠度水平，且无明显毒副作用，安全、有效。		
②安全性	临床观察患者未报道不良反应		
③经济性	--		
④病人可接受度	--		
⑤其他因素	--		

问题19：天麻钩藤饮适宜干预2级高血压肝火亢逆证患者吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 42个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	2362	2356	MD=-10.84，95% CI [-12.47，-9.21]	低
舒张压 42个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	2362	2356	MD=-8.41，95% CI [-9.65，-7.17]	低
临床疗效 37个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	严重	存在	2108	2102	OR=4.31，95% CI [3.76，5.89]	低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O结局指标
天麻钩藤饮适宜干预2级高血压肝火亢逆证患者吗？	1、2级高血压患者	天麻钩藤饮+常规治疗/天麻钩藤饮	常规治疗（奥美沙坦酯，氨氯地平，左旋氨氯地平，厄贝沙坦，非洛地平，比索洛尔，卡托普利，拉西地平，氯沙坦钾，依那普利，尼群地平，硝苯地平，缬沙坦，贝那普利）	收缩压、舒张压、临床疗效
研究类型及数量	43个RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-10.84，95% CI [-12.47，-9.21] 舒张压：MD=-8.41，95% CI [-9.65，-7.17] 临床疗效：OR=4.31，95% CI [3.76，5.89]			
证据等级	C级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不精确性			
结论	天麻钩藤饮适宜干预2级高血压肝火亢逆证患者			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓

详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	天麻钩藤饮适宜干预2级高血压肝火亢逆证患者 推荐意见：				
①证据等级	C级				
②疗效	一项纳入43篇RCT的META分析结果显示，天麻钩藤饮单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-10.84，95%CI [-12.47，-9.21]，舒张压：MD=-8.41，95% CI [-9.65，-7.17]，临床疗效：OR=4.31，95% CI [3.76，5.89]				
③安全性	10篇文献报告了恶心呕吐15例、腹痛腹泻12例，5篇文献报告了水肿13例，4篇文献报告了头晕头痛13例、面色潮红7例、心悸10例，除上述文献外其他纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题20：镇肝熄风汤适宜干预2级高血压阴虚阳亢证患者吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
SBP 17个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1079	1057	MD -12.14， 95CI[-15.29,-8.99]	中
DBP 17个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1079	1057	MD -7.16， 95CI[-9.06,-5.26]	中
不良反应 5个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	严重	存在	339	329	RR 0.29， 95CI[0.16,0.53]	低

共识问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O（结局指标）
镇肝熄风汤适宜干预2级高血压阴虚阳亢证患者吗？	2级高血压患者	镇肝熄风汤	常规治疗	SBP，DBP，不良反应
研究类型及数量	17个RCT			

效应值及可信区间	SBP:MD -12.14，95CI[-15.29,-8.99] DBP:MD -7.16，95CI[-9.06,-5.26] 不良反应:RR 0.29，95CI[0.16,0.53]
证据等级	C 级
是否升级或降级	降一级
升级或降级因素	局限性，发表偏倚
结论	镇肝熄风汤适宜干预 2 级高血压阴虚阳亢证患者

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	镇肝熄风汤适宜干预 2 级高血压阴虚阳亢证患者				
①证据等级	C 级				
②疗效	17 篇 RCT 的 META 分析结果显示，镇肝熄风汤联合降压药在降低收缩压、舒张压，改善临床疗效，降低中医症状积分，降低血脂方面疗效更为显著，安全性较好，SBP:MD -12.14，95CI[-15.29,-8.99]；DBP:MD -7.16，95CI[-9.06,-5.26]；不良反应:RR 0.29，95CI[0.16,0.53]				
③安全性	3 篇文献报告了腹泻，2 篇文献报告了心悸，3 篇文献报告了干咳，3 篇文献报告了皮疹，3 篇文献报高了踝部水肿，1 篇文献报告了颜面潮红，1 篇文献报告了呕吐，1 篇文献报告了肌肉痉挛，除上述文献外其他纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 21：半夏白术天麻汤适宜干预 2 级高血压痰湿壅盛证患者吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		

收缩压 7 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	275	275	MD=-6.76，95% CI [-8.44,-5.08]	低
舒张压 7 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	275	275	MD=-8.86，95% CI [-10.31，-7.42]	低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
半夏白术天麻汤适宜干预 2 级高血压痰湿壅盛证患者吗？	2 级高血压患者	半夏白术天麻汤+西药治疗	西药治疗	收缩压、舒张压
研究类型及数量	7 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-6.76，95% CI [-8.44 -5.08] 舒张压：MD=-8.86，95% CI [-10.31，-7.42]			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降 2 级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	半夏白术天麻汤适宜干预 2 级高血压痰湿壅盛证患者			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	半夏白术天麻汤适宜干预 2 级高血压痰湿壅盛证患者 推荐意见：				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 7 篇 RCT 的 META 分析结果显示，天麻钩藤饮单联合常规西药在收缩压、舒张压方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-6.76，95% CI [-8.44 -5.08]，舒张压：MD=-8.86，95% CI [-10.31，-7.42]				
③安全性	2 篇文献报告了肝肾功等安全性指标，除上述文献外其他纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 22：血府逐瘀汤合涤痰汤适宜干预 2 级高血压痰瘀互结证患者吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 38 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1652	1633	MD= -2.45，95% CI [-2.57，-2.34]	低
舒张压 38 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1652	1633	MD= -1.46，95% CI [-1.56，-1.37]	低
临床疗效 39 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1977	1928	MD= 4.33，95% CI [3.49，5.36]	低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
血府逐瘀汤合涤痰汤适宜干预 2 级高血压痰瘀互结证患者吗？	2 级高血压患者	血府逐瘀汤或涤痰汤+常规治疗/血府逐瘀汤或涤痰汤	常规治疗（苯磺酸氨氯地平，苯磺酸左旋氨氯地平，厄贝沙坦，非洛地平，富马酸比索洛尔，卡托普利，拉西地平，氯沙坦钾，尼群地平，硝苯地平，缬沙坦，贝那普利）	收缩压、舒张压、临床疗效
研究类型及数量	55 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD= -2.45，95% CI [-2.57，-2.34] 舒张压：MD= -1.46，95% CI [-1.56，-1.37] 临床疗效：MD= 4.33，95% CI [3.49，5.36]			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	血府逐瘀汤合涤痰汤适宜干预 2 级高血压痰瘀互结证患者			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大 强不推 一定不
推荐条目	血府逐瘀汤合涤痰汤适宜干预 2 级高血压痰瘀互结证患者 推荐意见：				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 55 篇 RCT 的 META 分析结果显示，血府逐瘀汤合涤痰汤单独应用或联合常规西药				

	压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-2.45，95%CI -2.34]，舒张压：MD=-1.46，95%CI[-1.56,-1.37]，临床疗效：MD=4.33，95%CI[3.49
③安全性	3 篇文献报告了头晕 4 例，恶心呕吐 4 例，3 篇文献报告了恶心呕吐，腹泻等反应 18 例，文献外其他纳入文献均未报道不良反应。
④经济性	--
⑤病人可接受度	--
⑥其他因素	--

问题 23：知柏地黄丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者吗？

基础问题	知柏地黄丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者吗？
研究类型及数量	共检索 1 篇文献 病案 1 篇
统计分析结果	知柏地黄丸干预高血压患者 3 例，收效良好
结论	结果显示， 知柏地黄丸可用于干预高血压患者

符号	↑	/	↓
详细描述	建议	中立	不建议
共识条目：	知柏地黄丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者 建议□ 中立□ 不建议□		
①疗效	知柏地黄丸干预高血压患者 3 例，收效良好		
②安全性	临床观察患者未报道不良反应		
③经济性	--		
④病人可接受度	--		
⑤其他因素	--		

问题 24：六味地黄丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	无	85	82	MD=-3.47，95% CI [-12.35，5.42]	极低
舒张压 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	无	85	82	MD=-2.06，95% CI [-2.35，-1.77]	极低

有效率 2 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	84	82	RR=1.17，95% CI [1.04,1.33]	低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
六味地黄丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者吗？	2 级高血压患者	六味地黄丸（六味地黄汤）+常规治疗	常规治疗（奥美沙坦酯，苯磺酸氨氯地平，苯磺酸左旋氨氯地平，厄贝沙坦，非洛地平，富马酸比索洛尔，卡托普利，拉西地平，氯沙坦钾，依那普利，尼群地平，硝苯地平，缬沙坦，贝那普利）	收缩压、舒张压、有效率
研究类型及数量	2 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-3.47，95% CI [-12.35，5.42] 舒张压：MD=-2.06，95% CI [-2.35，-1.77] 临床疗效：RR=1.17，95% CI [1.04,1.33]			
证据等级	D 级			
是否升级或降级	降三级			
升级或降级因素	局限性，不一致性，不精确性			
结论	六味地黄丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	六味地黄丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者 推荐意见：				
①证据等级	D 级				
②疗效	一项纳入 2 篇 RCT 的 META 分析结果显示，六味地黄丸（六味地黄汤）单独应用或联合常规西药在舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，在收缩压方面无显著差异。收缩压：MD=-3.47，95%CI [-12.35，5.42]，舒张压：MD=-2.06，95%CI [-2.35，-1.77]，临床疗效：RR=1.17，95% CI [1.04,1.33]。				
③安全性	纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 25：肾气丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阳虚）患者吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 7 个 RCT	无严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	311	249	MD=-5.12，95% CI [-9.90,-0.34]	中
舒张压 7 个 RCT	无严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	311	249	MD=-3.21，95% CI [-6.96,-0.54]	中
临床疗效 9 个 RCT	无严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	429	331	OR=2.67，95% CI [3.76, 5.89]	高

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
肾气丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阳虚）患者吗？	高血压患者	肾气丸	常规治疗（苯磺酸氨氯地平，苯磺酸左旋氨氯地平，卡托普利，依那普利，硝苯地平控释片，心痛定，珍菊降压片，消心痛，吲达帕胺，阿托伐他汀，）	收缩压、舒张压、临床疗效
研究类型及数量	11 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-5.12，95% CI [-9.90,-0.34] 舒张压：MD=-3.21，95% CI [-6.96,-0.54] 临床疗效：OR=2.67，95% CI [3.76, 5.89]			
证据等级	B 级			
是否升级或降级	降一级			

升级或降级因素	不一致性
结论	肾气丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阳虚）患者

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	肾气丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阳虚）患者 推荐意见：				
①证据等级	B 级				
②疗效	一项纳入 11 篇 RCT 的 META 分析结果显示，肾气丸单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-5.12，95% CI [-9.90,-0.34]舒张压：MD=-3.21，95% CI [-6.96,-0.54]临床疗效：OR=2.67，95% CI [3.76，5.89]				
③安全性	1 篇文献报告了不良反应，但未详细描述，1 篇文献报告了 2 组治疗前后血常 规、尿常规、肝肾功能均无明显改变，但对照组出现 1 例性功能明显下降，除上述文献外其他纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 26：针刺治疗能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 3 个 RCT	无严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	89	91	MD=-10.43，95%CI（-16.70，-4.17）	中
舒张压 3 个 RCT	无严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	89	91	MD=-7.38，95%CI（-11.81，-2.94）	中
中医证候积分 2 个 RCT	无严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	59	61	MD=-1.40，95%CI（-1.81，-0.98）	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标

针刺治疗能降低2级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？	2级高血压患者	针刺+常规治疗/天麻钩藤饮	常规治疗（苯磺酸左旋氨氯地平，硝苯地平，缬沙坦）	收缩压、舒张压、中医证候积分
研究类型及数量	3个RCT			
效应值及可信区间	收缩压：[MD=-10.43，95%CI（-16.70，-4.17），P<0.0001] 舒张压：[MD=-7.38，95%CI（-11.81，-2.94），P=0.001] 中医证候积分：[MD=-1.40，95%CI（-1.81，-0.98），P<0.0001]			
证据等级	B级			
是否升级或降级	降一级			
升级或降级因素	不一致性			
结论	针刺治疗能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大 强不推 一定不
推荐条目	针刺治疗能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状 推荐意见：				
①证据等级	B级				
②疗效	一项纳入3篇RCT的META分析结果显示，针刺联合常规西药在收缩压、舒张压方面均优于用常规西药治疗，收缩压：[MD=-10.43，95%CI（-16.70，-4.17），P<0.0001]，舒张压：[MD 95%CI（-11.81，-2.94），P=0.001]，中医证候积分：[MD=-1.40，95%CI（-1.81，-0.98），P<0				
③安全性	1篇文献报告了有5例患者针刺部位酸胀疼痛明显，2例患者出现局部小血肿，经局部按肿消失。除上述文献外其他纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题27：推拿能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 7个RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	255	245	MD=-4.34，95%CI（-5.80，-2.88）	极低

舒张压 6 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	205	195	MD=-3.61，95%CI（-4.69，-2.54）	极低
临床疗效 8 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	285	275	MD=1.86，95%CI（1.18，2.95）	极低
中医证候积分 5 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	165	155	MD=-2.97，95%CI（-3.43，-2.52）	极低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
推拿能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？	1、2 级高血压患者	推拿+常规治疗/推拿	常规治疗（苯磺酸氨氯地平，替米沙坦，盐酸贝那普利，马来酸依那普利，硝苯地平缓释片，硝苯地平控释片）	收缩压、舒张压、临床疗效、中医证候积分
研究类型及数量	8 个 RCT			
效应值及可信区间	SBP：MD=-4.34，95%CI（-5.80，-2.88） DBP：MD=-3.61，95%CI（-4.69，-2.54） 中医症候积分：RR =1.11，95%CI（1.13，1.09） 降压有效率：MD=-2.97，95%CI（-3.43，-2.52）			
证据等级	D 级			
是否升级或降级	降三级			
升级或降级因素	局限性，不一致性，不精确性			
结论	推拿能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	推拿能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状 推荐意见：				
①证据等级	D 级				

②疗效	一项纳入 8 篇 RCT 的 META 分析结果显示，推拿联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-4.34，95%CI（-5.80，-2.88），舒张压：MD=-3.61，95%CI（-4.69，-2.54），临床疗效：RR =1.11，95%CI（1.13，1.09），中医证候积分： MD=1.86，95%CI（1.18，2.95）。
③安全性	1 篇文献报告了 3 例患者服药后出现头痛，可接受，未停用。1 篇文献报告了药物组头痛加重 5 例，头晕加剧 2 例，心悸 2 例，踝部浮肿 2 例。除上述文献外其他纳入文献均未报道不良反应。
④经济性	--
⑤病人可接受度	--
⑥其他因素	--

问题 28：耳穴贴压能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	59	58	MD=--1.96，95% CI [-4.32 -0.39]	极低
舒张压 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	59	58	MD= -2.28，95% CI [-4.33，-0.24]	极低
临床疗效 2 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	67	99	MD=0.68，95% CI [0.16,2.92]	极低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
耳穴压豆能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？	2 级高血压患者	耳穴压豆+常规西药治疗/耳穴压豆	常规治疗（氯沙坦钾，硝苯地平，盐酸贝那普利，硝苯吡啶）	收缩压、舒张压、临床疗效
研究类型及数量	4 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD= -1.96，95% CI [-4.32 -0.39] 舒张压：MD= -2.28，95% CI [-4.33，-0.24] 临床疗效：MD=0.68，95% CI [0.16,2.92]			
证据等级	D 级			
是否升级或降级	降三级			
升级或降级因素	局限性，不一致性，不精确性			
结论	耳穴贴压能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓

详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	耳穴贴压能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状 推荐意见：				
①证据等级	D级				
②疗效	一项纳入4篇RCT的META分析结果显示，耳穴压豆单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-1.96，95% CI [-4.32 -0.39]，舒张压：MD= -2.28，95% CI [-4.33，-0.24]，临床疗效：MD=0.68，95% CI [0.16,2.92]				
③安全性	纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题29：中药足浴能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 26个RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1369	1356	MD=-6.88，95% CI [-7.99，-5.16]	低
舒张压 26个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1369	1356	MD=-6.50，95% CI [-8.02，-4.98]	中
降压疗效 22个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1096	1089	OR=3.93，95% CI [3.03，5.10]	中
症状疗效 17个RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	970	769	OR=4.69，95% CI [3.39，6.48]	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O结局指标
中药足浴能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	1、2级高血压患者	中药足浴+常规治疗	常规治疗（替米沙坦，氨氯地平，左旋氨氯地平，培哚普利，硝苯地平等）	收缩压、舒张压、降压疗效、症状疗效
研究类型及数量	38个RCT			

效应值及可信区间	收缩压：MD=-6.88，95% CI [-7.99，-5.16] 舒张压：MD=-6.50，95% CI [-8.02，-4.98] 降压疗效：OR=3.93，95% CI [3.03，5.10] 症状疗效：OR=4.69，95% CI [3.39，6.48]
证据等级	B 级
是否升级或降级	降一级
升级或降级因素	局限性
结论	中药足浴能降低 2 级高血压患者的血压，改善患者的中医症状

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	中药足浴能降低 2 级高血压患者的血压，改善患者的中医症状 推荐意见：				
①证据等级	B 级				
②疗效	一项纳入 38 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中药足浴联合常规西药在收缩压、舒张压、降压疗效、症状疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：收缩压：MD=-6.88，95% CI [-7.99，-5.16] 舒张压：MD=-6.50，95% CI [-8.02，-4.98]；降压疗效：OR=3.93，95% CI [3.03，5.10]；症状疗效：OR=4.69，95% CI [3.39，6.48]				
③安全性	2 篇文献报告了皮肤瘙痒 3 例，1 篇文献报告了干咳 11 例，1 篇文献报告了头晕头痛 13 例，除上述文献外其他纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 30：传统运动方式能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
SBP 31 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1412	1412	MD1.537，95%CI[1.00,6.16]	低
DBP 31 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	1412	1412	DBP:MD 1.062，95%CI[1.00,12.67]	低

共识问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O（结局指标）
传统运动方式能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	2级高血压患者	传统运动	常规治疗	①SBP②DBP
研究类型及数量	31个RCT			
效应值及可信区间	SBP:MD 1.537，95%CI[1.00,6.16] DBP:MD 1.062，95%CI[1.00,12.67]			
证据等级	C级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	传统运动方式能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	传统运动方式能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状 推荐意见：				
①证据等级	C级				
②疗效	一项纳入31篇RCT的META分析结果显示，传统运动方式能降低2级高血压患者的血压或改善患者的中医症状，SBP:MD 1.537，95CI[1.00,6.16];DBP:MD 1.062，95CI[1.00,12.67]				
③安全性	1篇文献报告了头痛、头晕、腹泻、便秘、心率增快，除上述文献外其他纳入文献均未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题30-1：八段锦能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
SBP 12 个 RCT	无严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	399	391	SMD= -0.72，95%CI [-0.87，-0.57]	低
DBP 12 个 RCT	无严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	399	391	SMD= -0.51，95%CI [-0.66，-0.37]	低

共识问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O（结局指标）
八段锦能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	2级高血压患者	八段锦	常规治疗	①SBP②DBP
研究类型及数量	12 个 RCT			
效应值及可信区间	SBP：SMD= -0.72，95%CI [-0.87，-0.57] DBP：SMD= -0.51，95%CI [-0.66，-0.37]			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	八段锦能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	八段锦降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状 推荐意见：				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 12 篇 RCT 的 META 分析结果显示，八段锦能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状，SBP：SMD= -0.72，95%CI [-0.87，-0.57];DBP：SMD= -0.51，95%CI [-0.66，-0.37]				
③安全性	未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 30-2：太极拳能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
SBP 15 个 RCT	无严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	316	416	SMD= 1.22，95%CI［1.07，1.37］	中
DBP 15 个 RCT	无严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	316	416	SMD= 0.63，95%CI［0.49，0.77］	低

共识问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O（结局指标）
太极拳能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	2 级高血压患者	太极拳	常规治疗	①SBP②DBP
研究类型及数量	31 个 RCT			
效应值及可信区间	SBP：SMD= 1.22，95%CI［1.07，1.37］ DBP：SMD= 0.63，95%CI［0.49，0.77］			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	太极拳能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	太极拳降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状 推荐意见：				
①证据等级	C 级				

②疗效	一项纳入 15 篇 RCT 的 META 分析结果显示，太极拳能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状，SBP：SMD= 1.22，95%CI［1.07，1.37］;DBP：SMD= 0.63，95%CI［0.49，0.77］
③安全性	未报道不良反应。
④经济性	--
⑤病人可接受度	--
⑥其他因素	--

问题 30-3：五禽戏能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
SBP 7 个 RCT	无严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	258	255	SMD = -0.36，95%CI［-0.55，-0.16］	中
DBP 7 个 RCT	无严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	258	255	SMD = -0.39，95%CI［-0.59，-0.24］	中

共识问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O（结局指标）
五禽戏能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	2 级高血压患者	五禽戏	常规治疗	①SBP②DBP
研究类型及数量	31 个 RCT			
效应值及可信区间	SBP：SMD = -0.36，95%CI［-0.55，-0.16］ DBP：SMD = -0.39，95%CI［-0.59，-0.24］			
证据等级	B 级			
是否升级或降级	降一级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	五禽戏能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	五禽戏能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状 推荐意见：				
①证据等级	C 级				

②疗效	一项纳入 31 篇 RCT 的 META 分析结果显示，五禽戏能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状，SBP：SMD = -0.36，95%CI [-0.55，-0.16];DBP：SMD = -0.39，95%CI [-0.59，-0.24]
③安全性	未报道不良反应。
④经济性	--
⑤病人可接受度	--
⑥其他因素	--

问题 32：珍菊降压片适宜干预 2 级高血压患者吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 8 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	522	517	MD=-3.43，95% CI [-12.99，6.12]	低
舒张压 8 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	522	517	MD=-0.07 ，95% CI [-4.25，4.4]	低
降压有效率 7 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	493	490	OR=1.4，95% CI [0.66，2.97]	低

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
珍菊降压片适宜干预 2 级高血压患者吗?	2 级高血压患者	珍菊降压片或珍菊降压片+西药	西药	收缩压、舒张压、降压有效率
研究类型及数量	8 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-3.43，95% CI [-12.99，6.12] 舒张压：MD=-0.07 ，95% CI [-4.25，4.4] 降压有效率：OR=1.4，95% CI [0.66，2.97]			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	珍菊降压片适宜干预 2 级高血压患者			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	珍菊降压片适宜干预 2 级高血压患者 推荐意见：				
①证据等级	C 级				

②疗效	一项纳入 8 篇 RCT 的 META 分析结果显示，珍菊降压片单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-3.43，95% CI [-12.99，6.12]，舒张压：MD=-0.07 ，95% CI [-4.25，4.4]，降压有效率：OR=1.4，95% CI [0.66，2.97]。
③安全性	未报道不良反应。
④经济性	--
⑤病人可接受度	--
⑥其他因素	--

问题 33：松龄血脉康适宜干预 2 级高血压患者吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 5 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	227	203	MD=-6.02，95% CI [-11.71，-0.33]	低
舒张压 3 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	136	124	MD=-4.54，95% CI [-8.53，-0.55]	低
降压有效率 5 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	无	229	215	RR=1.10，95% CI [1.01，1.19]	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
松龄血脉康适宜干预 2 级高血压患者吗?	2 级高血压患者	松龄血脉康或松龄血脉康+西药	西药	收缩压、舒张压、降压有效率
研究类型及数量	6 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-6.02，95% CI [-11.71，-0.33] 舒张压：MD=-4.54，95% CI [-8.53，-0.55] 降压有效率：RR=1.10，95% CI [1.01，1.19]			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	松龄血脉康适宜干预 2 级高血压患者			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	松龄血脉康适宜干预 2 级高血压患者				

	推荐意见：弱推荐
①证据等级	C 级
②疗效	基于 6 篇 RCT 的 META 分析结果显示，松龄血脉康联合常规药物在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规药物治疗，收缩压：MD=-6.02，95% CI [-11.71，-0.33]，舒张压：MD=-4.54，95% CI [-8.53，-0.55]，降压有效率：RR=1.10，95% CI [1.01，1.19]。
③安全性	未报道不良反应。
④经济性	--
⑤病人可接受度	--
⑥其他因素	--

问题 34：牛黄降压丸适宜干预 2 级高血压患者吗？

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
降压有效率 3 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	存在	247	207	OR=6.25，95% CI [1.97,19.83]	低
收缩压 3 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	247	207	MD=-8.49 ，95% CI [-15.70,-1.28]	低
舒张压 3 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	247	207	MD=-2.44，95% CI [-4.52,-0.36]	中

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
牛黄降压丸适宜干预 2 级高血压患者吗?	2 级高血压患者	牛黄降压丸	常规西药	收缩压、舒张压、降压有效率
研究类型及数量	3 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=-8.49 ，95% CI [-15.70,-1.28] 舒张压：MD=-2.44，95% CI [-4.52,-0.36] 降压有效率：OR=6.25，95% CI [1.97,19.83]			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	牛黄降压丸可协助治疗 2 级高血压。			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓

详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	牛黄降压丸可协助治疗 2 级高血压。 推荐意见：弱推荐				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 3 篇 RCT 的 META 分析结果显示，牛黄降压丸单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-8.49 ，95% CI [-15.70,-1.28]，舒张压：MD=-2.44，95% CI [-4.52,-0.36]，降压有效率：OR=6.25，95% CI [1.97,19.83]				
③安全性	未报道不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

问题 35： 心可舒片适宜干预 2 级高血压患者吗?

质量评价						结果总结			
研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		危险度	质量
						治疗组	对照组		
收缩压 9 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	469	470	MD=--8.56，95% CI [-13.04，-4.08]	低
舒张压 9 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	469	470	MD=-7.09，95% CI [-9.65，-4.52]	低
降压有效率 3 个 RCT	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	139	139	OR=3.93，95% CI [1.43，10.80]	中
室间隔厚度 6 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	377	378	MD=-0.92，95% CI[-1.49，-0.34]	低
左室壁厚度 5 个 RCT	严重局限	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	377	378	MD=-0.88，95% CI [-1.41，-0.34]	低
左室舒张末内径 4 个 RCT	严 重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	存在	267	267	MD=-1.87，95% CI [-2.91，-0.82]	中
左室质量指数 3 个 RCT	严重局限	无严重不一致	无严重间接性	无严重不精确	存在	205	206	MD=-5.24，95% CI [-10.02，-0.47]	中

		性		性					

临床问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O 结局指标
心可舒片适宜干预 2 级高血压患者吗?	2 级高血压患者	心可舒+常规西药（常规西药同对照组）	常规西药	收缩压、舒张压、降压有效率、不良反应率、室间隔厚度、左室壁厚度、左室舒张末内径、左室质量指数
研究类型及数量	9 个 RCT			
效应值及可信区间	收缩压：MD=--8.56，95% CI [-13.04，-4.08] 舒张压：MD=-7.09，95% CI [-9.65，-4.52] 降压有效率：OR=3.93，95% CI [1.43，10.80] 室间隔厚度：MD=-0.92，95% CI[-1.49，-0.34] 左室壁厚度：MD=-0.88，95% CI [-1.41，-0.34] 左室舒张末内径：MD=-1.87，95% CI [-2.91，-0.82] 左室质量指数：MD=-5.24，95% CI [-10.02，-0.47]			
证据等级	C 级			
是否升级或降级	降二级			
升级或降级因素	局限性，不一致性			
结论	心可舒适宜干预 2 级高血压患者			

符号	↑↑	↑	/	↓	↓↓
详细描述	明显利大于弊 强推荐 一定做	可能利大于弊 弱推荐 可能做	利弊相当或不确定 无明确推荐意见	可能弊大于利 弱不推荐 可能不做	明显弊大于利 强不推荐 一定不做
推荐条目	中成药适宜干预 2 级高血压患者 推荐意见：				
①证据等级	C 级				
②疗效	一项纳入 49 篇 RCT 的 META 分析结果显示，心可舒单独应用或联合常规西药在收缩压、舒张压、降压有效率、室间隔厚度、左室壁厚度、左室舒张末内径、左室质量指数等方面均优于单独应用常规西药治疗，收缩压：MD=-8.56，95% CI [-13.04，-4.08]，舒张压：MD=-7.09，95% CI [-9.65，-4.52]，降压有效率：OR=3.93，95% CI [1.43，10.80]，室间隔厚度：MD=-0.92，95% CI[-1.49，-0.34]，左室壁厚度：MD=-0.88，95% CI [-1.41，-0.34]，左室舒张末内径：MD=-1.87，95% CI [-2.91，-0.82]，左室质量指数：MD=-5.24，95% CI [-10.02，-0.47]。				
③安全性	0 篇文献报告有不良反应。				
④经济性	--				
⑤病人可接受度	--				
⑥其他因素	--				

（七）推荐意见

1.推荐意见形成方法

推荐意见考虑利弊权衡、证据质量高低、患者的偏好和价值观、成本（资源分配）等因素，由名义组会议专家综合权衡后作出推荐强度。本共识基于 GRADE

网格，分三轮进行投票，达成共识规则如下：除了“中间”格以外的任何 1 格票数超过 50%，则达成共识，可直接确定推荐方向及强度；若“中间”格某一侧两格总票数超过 70%，则达成共识，可确定推荐方向，推荐强度为“弱”。其余情况视为未达成共识，推荐意见进入下一轮投票，投票不得超过三轮。最终，由共识秘书处统计并汇总推荐意见及强度。

2.推荐意见投票结果

如采用GRADE网格计票法对推荐条目进行计票，需列出每条推荐意见的投票结果，见表5。

表 5 推荐意见投票结果表

序号	推荐条目	推荐方向强度的票数					投票轮数	是否达成共识
		↑↑	↑	／	↓	↓↓		
1	2 级高血压（中危）的患者，可否联用中医药疗法协助控制血压？	√					1	是
2	2 级高血压（中/高危）的患者，可否联用中医药疗法协助控制血压？	√					1	是
3	2 级高血压（高危）的患者，可否联用中医药疗法协助控制血压？	√					1	是
4	2 级高血压（很高危）的患者，可否联用中医药疗法协助控制血压？		√				1	是
5	对于存在症状的 2 级高血压（中危）患者，可否联用中医药疗法协助改善症状？	√					1	是
6	对于存在症状的 2 级高血压（中/高危）患者，可否联用中医药疗法改善症状？	√					1	是
7	对于存在症状的 2 级高血压（高危）患者，可否联用中医药疗法协助改善症状？	√					1	是
8	对于存在症状的 2 级高血压（很高危）患者，可否联用中医药疗法协助改善症状？		√				1	是
9	对于 2 级高血压患者，是否联用中医药疗法协助防治靶器官损伤（心、脑、肾）？		√				1	是
10	对于伴冠心病、糖尿病、心衰、肾功能不全、高脂血症等疾病的 2 级高血压（很高危）患者，是否联用中医药疗法协助降压？	√					1	是
11	2 级高血压（中危）患者常规西药治疗后血压波动大者是否适宜联合中医药疗法协助降压？	√					1	是
12	2 级高血压（中/高危）患者常规	√					1	是

	西药治疗后血压波动大者是否适宜联合中医药疗法协助降压？							
13	2 级单纯收缩期高血压患者是否适宜联合中医药疗法协助降压？	√					1	是
14	在改善生活方式的基础上，血压仍高于 160/100mmHg 的 2 级高血压患者，是否联用中医药疗法协助控制血压？	√					1	是
15	2 级高血压的患者，可否在生活方式干预的基础上联用中医养生调摄等方法来协助降压？	√					1	是
16	对于中医疗法意愿强烈的 2 级高血压患者，可否联用中医药疗法以协助控制血压	√					1	是
17	在改善生活方式的基础上，应用多种降压药物，治疗后血压达标且有减药需求的 2 级高血压患者，是否联用中医药疗法协助控制血压？	√					1	是
18	2 级高血压患者的常见证候类型可以归结为肝郁气滞证、肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证吗？	√					1	是
19	柴胡疏肝散适宜干预 2 级高血压肝郁气滞证患者吗？	√					1	是
20	天麻钩藤饮适宜干预 2 级高血压肝火亢逆证患者吗？	√					1	是
21	镇肝熄风汤适宜干预 2 级高血压阴虚阳亢证患者吗？	√						是
22	半夏白术天麻汤适宜干预 2 级高血压痰湿壅盛证患者吗？	√					1	是
23	血府逐瘀汤合涤痰汤适宜干预 2 级高血压痰瘀互结证患者吗？		√				1	是
24	知柏地黄丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者吗？	√					1	是
25	六味地黄丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者吗？		√				1	是
26	肾气丸适宜干预 2 级高血压阴阳两虚证（偏阳虚）患者吗？	√					1	是
27	中成药适宜干预 2 级高血压患者吗？	√					1	是
28	松龄血脉康适宜干预 2 级高血压患者吗？		√				1	是
29	牛黄降压丸适宜干预 2 级高血压患者吗？		√				1	是
30	珍菊降压片适宜干预 2 级高血压患者吗？	√					1	是
31	心可舒片适宜干预 2 级高血压患者吗？		√				1	是
32	针刺治疗能降低 2 级高血压患者	√					1	是

	的血压或改善患者的症状吗？							
33	推拿能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？		√				1	是
34	耳穴贴压能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	√					1	是
35	中药足浴能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	√					1	是
36	传统运动方式能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	√					1	是
37	八段锦能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	√					1	是
38	太极拳能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	√					1	是
39	五禽戏能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？	√					1	是
40	耳尖放血能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？		√				1	是
41	穴位贴敷能降低2级高血压患者的血压或改善患者的症状吗？		√				1	是

（八）撰写指南草案

本共识由山东中医药大学附属医院秘书处执笔，草案初步完成于2022年8月25日。2022 年 8 月 28 日采用腾讯会议线上的方式召开“草案确定会”。共有 24 位专家参加，邀请方法学专家天津中医药大学翟静波教授主持会议，对我们的草案进行讨论，所有专家依次发言，提出了修改意见，我们根据专家意见对草案进行详细的修改，确定最终草案。

（九）指南草案的质量评价及适用性评价

1.质量评价

根据中华中医药学会团体标准（指南类）质量评价表，我们邀请循证医学、临床、药学等方面的4位专家做出共识质量及适用性评价。分别是山东中医药大学附属医院辛义周，应急总医院常富业，首都医科大学附属北京中医医院尚菊菊，山东宏济堂制药集团股份有限公司孟兆青。

以表格形式汇总指南的质量评价结果，见表6。

表 6 指南质量评价结果

序号	条目内容	选择人数		
		是	否	不适用
1	指南制订小组由包含临床专家和方法学家在内的多学科团队组成	4		
2	指南制订人员与指南内容无利益冲突	4		
3	有构建清楚的临床问题	4		

3.1	报告了中医病名或西医病名或具体中医证候	4		
3.2	报告了干预措施的具体类型如汤药、中成药、针灸等	4		
3.3	对照措施合理			4
3.4	结局指标是具有临床重要性，或能体现中医药治疗优势的指标	4		
4	检索范围全面	4		
4.1	检索内容包括了中医古籍文献与现代临床研究文献	4		
4.2	报告了检索的数据库、检索时间、检索词	4		
4.3	提供了代表数据库的具体检索策略	4		
5	提供了纳入排除标准，并与临床问题相符	4		
6	描述了文献筛选过程，并提供了清晰的筛选流程图	4		
7	提供了排除文献列表			
8	数据提取过程清晰	4		
9	提供了纳入文献清单及纳入文献特征表	4		
10	数据综合过程正确	4		
10.1	效应值选择正确	4		
10.2	统计分析方法正确	4		
11	选用了国际或行业内公认的证据质量评价方法，且证据质量评价过程正确，前后无矛盾	4		
12	提供了证据概要表	4		
13	明确描述形成推荐意见的考虑要素	4		
14	明确解释推荐强度的含义	4		
15	明确描述形成推荐意见的方法，并提供了相关附件如调研问卷或会议记录	4		
16	每条推荐意见均有证据支持	4		

2.适用性评价

根据中华中医药学会团体标准（指南类）适用性评价表，我们邀请循证医学、临床、药学等方面的4位专家做出共识质量及适用性评价。分别是中国中医科学院西苑医院徐浩、济南市中医医院张红星、山东第一医科大学第一附属医院李晓鲁、山东中医药大学附属医院谭奇纹。

对适用性评价的主要结果进行总结，同时以表格形式汇总指南的适用性评价结果，见表7。

表 7 指南适用性评价结果

序号	条目	选择人数		
		是	否	不适用
领域1. 总体				
1	制定的机构组织及成员具有权威性	4		
2	明确定义指南使用人群（中医医师/中西医结合医师/西医医师等）	4		
3	明确定义指南适用环境（三级医院/二级医院/社区诊疗中心等）	4		
4	指南内容全面	4		
5	理、法、方、药一致	4		
领域2. 清晰性				

1	推荐建议易于识别（在框中加粗，粗体文字，下划线等）	4		
2	推荐意见表达用词明确，并列出每项推荐意见的证据等级	4		
3	列出指南内包含的所有术语和英文译名，及其具体定义	4		
4	指南中的临床问题明确，且与推荐意见前后一致	4		
领域3. 可执行性				
1	指南使用人员可以理解指南内容	4		
2	明确定义患者人群特征，必要时应列出不适用的亚组人群	4		
3	疾病的病因清晰，有依据，并得到行业认同	4		
4	疾病的病机清晰，有依据，并得到行业认同	4		
5	中医常见证候清晰，有依据，并得到行业认同	4		
6	对于推荐的方药，明确描述了具体组方	4		
6.1	报告了方剂名称；	4		
6.2	报告了方剂来源；	4		
6.3	报告了方剂组成及每味中药的克数；	4		
6.4	报告了用药方案；	4		
6.5	报告了煎煮法（需要时列出）；	4		
6.6	报告了加减用药方案（需要时列出）；	4		
6.7	报告了注意事项	4		
6.8	如果有合并治疗，描述合并治疗方案	4		
6.8.1	合并治疗类型	4		
6.8.2	合并治疗时机	4		
6.8.3	合并治疗剂量/频次	4		
6.8.4	合并治疗疗程	4		
6.9	明确描述该方剂改善的结局	4		
7	对于中成药，明确描述了下列信息	4		
7.1	报告了用药方案；	4		
7.2	报告了疗程；	4		
7.3	报告了注意事项	4		
7.4	如果有合并治疗，描述合并治疗方案	4		
7.4.1	合并治疗类型	4		
7.4.2	合并治疗时机		4	
7.4.3	合并治疗剂量/频次	4		
7.4.4	合并治疗疗程		4	
7.5	明确描述该中成药改善的结局	4		
7.6	该中成药是否属于医保药物或基药	4		
8	对于非药物疗法（如针刺，推拿等），提供足够详细信息，以允许临床医师可以进行相关操作	4		
8.1	针刺	4		
8.1.1	报告了针刺的穴位		4	
8.1.2	报告了针刺的深度		4	
8.1.3	报告了针刺的刺激方式		4	
8.1.4	报告了留针时间		4	
8.1.5	报告了治疗频次	4		
8.1.6	报告了疗程	4		
8.1.7	必要时报告联用的其他干预措施	4		
8.1.8	明确描述该疗法改善的结局	4		
8.2	灸法			4
8.2.1	报告了灸法的适用情况			4
8.2.2	报告了某灸法的操作要点			4

8.2.3	报告了治疗频次			4
8.2.4	报告了灸法的疗程			4
8.2.5	明确描述该疗法改善的结局			4
8.3	推拿			4
8.3.1	报告了推拿手法			4
8.3.2	报告了推拿时间			4
8.3.3	报告了治疗频次			4
8.3.4	报告了疗程			4
8.3.5	明确描述该疗法改善的结局			4
8.4	针刀疗法			4
8.4.1	报告了无菌操作要点			4
8.4.2	报告了进针的取穴部位			4
8.4.3	报告了进针的深度			4
8.4.4	报告了进针手法的操作要点			4
8.4.5	报告了治疗频次			4
8.4.6	报告了疗程			4
8.4.7	必要时报告联用的其他干预措施（如推拿）			4
8.4.8	明确描述该疗法改善的结局			4
8.5	敷贴、熏洗	4		
8.5.1	报告了贴敷片剂治疗的部位或熏洗的部位	4		
8.5.2	报告了治疗频次	4		
8.5.3	报告了疗程	4		
8.5.4	必要时报告联用的其他干预措施	4		
8.5.5	明确描述该疗法改善的结局	4		
8.6	耳穴			
8.6.1	报告了耳穴刺激的穴位		4	
8.6.2	报告了治疗频次	4		
8.6.3	报告了疗程	4		
8.6.4	必要时报告联用的其他干预措施	4		
8.6.5	明确描述该疗法改善的结局	4		
8.7	传统功法（太极、气功等）	4		
8.7.1	报告了具体功法的名称	4		
8.7.2	报告了练功的频次与时长	4		
8.7.3	报告了练功的注意事项	4		
8.8	其他非药物疗法			4
9	必要时可针对性提出预防调护的措施			4
10	必要时可针对性提出康复调摄的措施			4

3.评价结果分析

从中华中医药学会团体标准（指南类）质量评价表可以看出，4位专家一致认为共识的总体质量较高，并愿意推荐使用该指南。本共识开发过程中采用了科学的方法和严谨的策略，保证最终形成合适的推荐建议，共识开发的方法学和策略的质量获得专家们的一致认同。从中华中医药学会团体标准（指南类）适用性评价表可以看出，4位专家一致认为共识的适用性较强，并愿意推荐使用该指南。并对质量评价和适用性评价结果进一步分析，根据其结果，修改完善指南草案，

形成征求意见稿。

（十）征求意见

工作组于2022年9月1日至9月30日将指南征求意见稿和编制说明等材料通过邮件的方式向全国34位专家开展征求意见工作，共有34位专家给予回复。

回复征求意见专家名单：北京市安贞医院/康铁朵、首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋、空军军医大学第一附属医院/孙冬冬、山东第一医科大学第一附属医院心内科/侯应龙、应急总医院/常富业、山东宏济堂制药集团股份有限公司/孟兆青、中国中医科学院西苑医院/高蕊、南京中医药大学附属医院/严冬、中国中医科学院广安门医院/吴敏、辽宁中医药大学附属医院/刘彤、辽宁省人民医院/王胜勇、湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清、广西国际壮医医院/姜益宏、广西国际壮医医院/徐先增、新疆医科大学附属中医医院/李鹏、空军军医大学第一附属医院/刘海涛、新疆自治区乌鲁木齐市中医医院/邓德强、浙江中医药大学/万海同、黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷、黑龙江中医药大学附属第一医院/蒋宁、南京中医药大学附属医院/常诚、辽宁中医药大学/贾连群、长春中医药大学附属医院/王健、长春中医药大学附属医院/邓悦、浙江中医药大学/季旭明、山东第一医科大学第一附属医院/李欣然、江苏省中医院/王永生、黄怀鹏/石家庄平安医院、李庆华/石家庄白求恩国际和平医院、山东省立医院/赵雪梅、首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊、内蒙古自治区人民医院/斯琴高娃、内蒙古医科大学附属医院/韩额尔德木图。

征求意见最终共收到133条专家意见，其中无建议15条。项目工作组按照“循证”等原则逐条对反馈的意见进行研究处理，最终采纳及部分采纳意见67条，未采纳意见51条，并一一提出了理由。

将收到的反馈意见归纳汇总和研究处理，给出“采纳”“部分采纳”或“未采纳”的处理意见，汇总形成意见汇总处理表。对于“未采纳”和“部分采纳”的反馈意见，应当说明理由。见表8。

表 8 征求意见汇总处理表

序号	章条编号	提出单位和姓名	草案内容	反馈意见内容及理由	意见处理情况
1	第 1 页	北京市安贞医院/康铁朵	高血压与二级高血压分级可否用同	统一标准	未采纳。并未出自不同的指南

			一版指南		
2	第 9 页	北京市安贞医院/康铁朵	“联合标准治疗”改“联合药物治疗”	联合标准治疗说法不规范	已采纳
3	第 16 页	北京市安贞医院/康铁朵	收缩压写两遍	笔误，可以删掉	已采纳
4	1	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	高血压治疗目标是降低高血压的心脑肾与血管并发症发生和死亡的总危险	总危险能否改为总风险？原因是降低…风险	已采纳
5	3	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	证据概要：一项纳入 4 项 RCT 的 META 分析显示，中药汤剂、针刺、耳穴贴压联 合常规药物治疗在降低收缩压和舒张压方面优于单纯规范降压方案	是否需要明确中药汤剂的具体名字？原因是 META 分析里面肯定有具体的中药汤剂名字，这样才具有说服力	部分采纳。如需方剂内容参考文献中可查，未提及的方剂均非经方
6	3	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	证据概要：一项纳入 3 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中药汤剂单独应用或联合 常规药物在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规药物治疗，收缩压	是否需要明确中药汤剂的具体名字？原因是 META 分析里面肯定有具体的中药汤剂名字，这样才具有说服力	部分采纳。如需方剂内容参考文献中可查，未提及的方剂均非经方
7	3	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	一项纳入 3 项 RCT 的 META 分析显示，中药汤剂或针刺联合常规药物治疗，在降低 收缩压和舒张压方面优于单纯规范降压方案	是否需要明确中药汤剂的具体名字？原因是 META 分析里面肯定有具体的中药汤剂名字，这样才具有说服力	部分采纳。如需方剂内容参考文献中可查，未提及的方剂均非经方
8	3	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	一项 META 分析显示，改善心肌损害方面，常规药物联合中成药组的左 心室质量指数均显著低于常规药物组。一项 RCT 的结果显示，依那普	是否需要明确中成药组的具体名字？原因是 META 分析里面肯定有具体的中药汤剂名字，这样才具有说服力	部分采纳。如需方剂内容参考文献中可查，未提及的方剂均非经方

			利联合中医药治疗 2 级高血压合并左室肥厚总有效率为94.44%，显著高于单纯依那普利治疗。对于改善肾损伤 方面，有一项 META 分析显示，ARB、ACEI、ARB+CCB 或 CCB 联合中药治疗降低尿 10 微量白蛋白，优于单纯 ARB、ACEI、ARB+CCB 或 CCB		
9	3	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	证据概要：对于合并冠心病的患者，应用中药汤剂联合常规药物治疗对比常规药物治疗，在控制血压、缓解冠心病症状、改善心功能上均有更好的疗效。	是否需要明确中药汤剂的具体名字？（是否是血府逐瘀汤？）原因是试验里面肯定有具体的中药汤剂名字，这样才具有说服力	部分采纳。如需方剂内容参考文献中可查，未提及的方剂均非经方
10	5.1 治疗原则	空军军医大学第一附属医院/孙冬冬	其中部分有糖尿病，蛋白尿等的高危患者，更改为“其中有糖尿病，脑卒中，心力衰竭，慢性肾脏疾病等疾病的高危患者”	更加全面的描述高危患者	已采纳
11	5.1	山东第一医科大学第一附属医院心内科/侯应龙	在陈述常用降压药分类时，是否应该增加 ARNI?以体现与时俱进	因为国家食药局已经批准诺心妥为高血压适应证	已采纳
12	5.3 临床问题 7	山东第一医科大学第一附属医院心内科/侯应龙	列举了 5 种伴随情况，是否可以删除缺乏证据的 2 种情况（心衰与肾功能不全）	在推荐意见里面只回答了冠心病，糖尿病与高脂血症，而且回答的逻辑顺序与问题中罗列的逻辑顺序不一致	未采纳。推荐意见中并未推荐缺乏证据的两种情况，临床问题为专家提出，未轻易修改
13	参考文献	山东第一医科大学	对于杂志级别较	低级别杂志与小样本量文章的可信度	未采纳。中医类别普遍证据较低

		第一附属医院心内科/侯应龙	低,30-50 例样本量的经验报道是否要采录,可以再斟酌	降低,会影响整个诊疗方案的权威性与可信度	
14	2 规范性引用文件	山东中医药大学附属医院/辛义周	《中华人民共和国药典（2015 年版）》建议改为《中华人民共和国药典（2020 年版）》	新版药典已经实施 2 年，建议引用最新版本	已采纳
15	第 7 页倒数 10 行、倒数 7 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	纳入 4 篇...和纳入 3 项...引用的文献都是 3 篇？		已采纳
16	第 9 页倒数 16 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	“联合标准治疗”建议改为“联合常规药物治疗”	其他各处基本都是“联合常规药物治疗”	已采纳
17	第 11 页倒数 7 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	“+常规药物治疗单独应用或”建议改为“单独应用或”或删掉，需要根据文献内容	跟前后文的表述不一致	已采纳
18	第 12 页正数 6 行、7 行、8 行，倒数 9 行、10 行、11 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	“枸杞”建议改为“枸杞子”，“生石决”建议改为“石决明”，“生杜仲”建议改为“杜仲”，“白菊花”建议改为“菊花”	按照药典，枸杞子是规范名称，写石决明、杜仲就是指生品，无需注明“生”，药典无白菊花的说法。	已采纳
19	第 14 页上边第 10 行、倒数第 8 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	“芍药”建议明确为”白芍”或”赤芍”，“生龟板、生代赭石、生龙骨、生牡蛎、生麦芽”建议去掉“生”	药典无芍药的说法，按照药典，这些药品如果是生品，无需标记“生”。	已采纳
20	第 15 页上边第 5 行，第	山东中医药大学附属医院/辛义周	5 行的“生地”建议改为“生地黄”、17 行		已采纳

	17 行，倒数 11 行，倒数 6 行		MD=-3.47，95% CI [-12.35，5.42]是否有误？倒数 11 行“干地黄”，有鲜地黄、生地黄、熟地黄，没有干地黄的说法，倒数 6 行的 OR=2.67，95% CI [3.76，5.89]是否有误？		
21	第 16 页倒数 10 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	两个“收缩压”，可删去一个		已采纳
22	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		临床问题 3：2 级高血压患者，可否联用中医药疗法协助控制血压？推荐意见 1：2 级高血压（中危）患者，在常规药物治疗的基础上，联用中医药疗法以 协助控制血压。辨证加用中药汤剂（补益肝肾方），合理配合中医适宜技术（针刺、耳穴贴压）以提高疗效。（证据级别：C 级 推荐强度：强推荐），一般情况下，证据级别 C 很难强推荐，推荐的理由需要解释，另外需要明确是哪一个措施强推荐，药汤剂（补益肝肾方）？针刺？耳穴贴压？不应该都是强推荐	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
23	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		推荐意见 4：2 级高血压（很高危）患者在血压增高的同时已经伴发了临床疾病，在常规药物治疗的基础上，辨证联用中药汤剂（半夏白术天麻汤），以提高疗效。（证据级别： C 级 推荐强度：弱推荐。这个临床问题疗效结果表述不清晰，干预措施是针对伴发疾病的还是针对高血压的，如果针对	未采纳。虽针对高血压，但针对的是很高危分层的患者

				高血压的，已经有相关条目了，如果针对伴发疾病的，疗效指标不吻合，请解释确认	
24	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		临床问题 5：2 级高血压患者血压波动大者，是否适宜常规药物联合中医药疗法协助降压？ 推荐意见 1：2 级高血压（中危）患者血压波动大，在常规药物治疗的基础上，辨证联用中药汤剂（石决牡蛎汤）以平稳降压。（证据级别：D 级 推荐强度：强推荐。证据级别 D 强推荐需慎重，并解释原因	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
25	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		推荐意见 2：2 级高血压（中/高危）患者已合并危险因素，对于血压波动大的 2 级高血 压（中/高危）患者，在常规药物治疗基础上，可辨证联用中药汤剂（钩藤四物汤、活血柔 肝方）以平稳降压。（证据级别：D 级 推荐强度：强推荐。证据级别 D 强推荐需慎重，并解释原因	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
26	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		临床问题 11：中成药适宜干预 2 级高血压患者吗？，这个临床问题太大，不是所有的中成药都适合高血压患者，建议回归品种论述	未采纳。所列举中成药均于编制说明中列举，且已推荐重点药物
	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		临床问题 12：中医经典方剂（柴胡疏肝散、天麻钩藤饮、镇肝熄风汤、半夏白术天麻 汤、血府逐瘀汤合涤痰汤、六味地黄丸、肾气丸）适宜协助干预 2 级高血压患者吗。有些处方前面已经提到了，并推荐了，再问是重复的，有些没有提到的处方需要单独论述，不应该合在一起。	未采纳。前面的方剂并未按证型进行有效推荐
27	5.3 临床	中国中医科		整体指南存在证据	

	问题	学院西苑医院/高蕊		级别不高，强推荐过多的情况，建设慎重评估解释	
28	P6 以后	南京中医药大学附属医院/严冬	多处证据级别与推荐强度不匹配（如：证据级别：D 级 推荐强度：强推荐）	没有依据 GRADE	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
29	P7	南京中医药大学附属医院/严冬	推荐意见 2 辨证联用中成药（复方丹参滴丸）中“辨证”是否应该为具体证型（比如血瘀证）。文中还有多处类似的情况	因为复方丹参滴丸是有明确功效的，因而具有特定证型。另外在推荐说明里需要就推荐该药的症状作详细说明。其它有中成药的地方建议一并修改，保证药证配合，减少使用误区。	未采纳。为格式统一
30	P14	南京中医药大学附属医院/严冬	柴胡舒肝散只有一个临床研究	临床上这种超早期的肝郁较难在 2 级高血压中持续看到，要不已经化火，要不就是阳亢。柴胡疏肝散中的药物成分特别是芸香科属的易化燥伤阴，升高血压，不适合临床长期使用。	未采纳。证据确实欠充分，但已经专家论证中药的组方配伍可减轻化燥伤阴的作用
31		南京中医药大学附属医院/严冬	建议用中药成方或者中成药均说明适用的症状，方证对应，减少非中医专业人士使用方案时的误解。 中药复方的使用时间、方法、什么时候调整药方是否要另外加以说明，甚则有时需要将用量也要写个范围，因为基于西医的认识，都是以 1g 一下作为		部分采纳。用法用量已经完善，对于克为单位，不适用于中成药（中成药多数以粒或者袋为规格）

			用量单位，所以临床常见西医用中成药经常1粒1次，这样不会发挥中药的应有作用，还留下中医中药没用的坏名声		
32	6诊疗流程图	中国中医科学院广安门医院/吴敏	“中医意愿强烈”患者建议增加“中医适宜技术”	临床中这部分患者采用中药汤剂+中医适宜技术，临床疗效较好	未采纳。无证据
33	1	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	本诊疗方案适合各级医疗机构中从事高血压临床工作的相关人员使用	建议考虑西医临床医生是否合适	未采纳。过于局限
34	4.1.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	表（2）血压后应加mmHg,	血压后应有单位，更严谨	已采纳
35	4.1.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	表(2)第一列罗马数字建议删除	更简洁	已采纳
36	4.1.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	表（1）表（2）后建议加备注表（1）注：以上诊断标准适用于成人，当收缩压和舒张压分属于不同级别时，以较高级别作为标准。表（2）注：CKD,慢性肾脏疾病。	更严谨	已采纳
37	5.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	辨证加用中药汤剂（补益肝肾方）建议去掉（补益肝肾方）	辨证加用中药汤剂表述更严谨，或（）内多加几个方子，避免错觉为都用补益肝肾方。	已采纳
38	5.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	辨证联用中药汤剂（枸杞子、女贞子、杜仲、天麻、钩藤、牛膝、鸡血藤)/中成药	表述不严谨中药汤剂括号内均为中药饮片，中成药括号推荐药物单一容易误解。建议修订。	已采纳

			（复方丹参滴丸）		
39	5.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	，辨证联用中药汤剂（半夏白术天麻汤)/中成药（血府逐瘀胶囊）	临床问题3-5表述有些凌乱不太清楚，建议重新归纳总结。建议辨证联用改为某证用某方，因为荟萃分析用的研究也是针对具体证型。	部分采纳。荟萃分析用的研究针对具体证型，但该临床问题并不针对具体证型，只是有该证型的证据
40	5.3临床问题5	辽宁省人民医院/王胜勇	血压波动大可以进一步概括为血压变异性大	研究显示，血压变异性大为心血管事件增高的独立危险因素，降压血压的变异性也是中医药实现高质量降压的一个体现	已采纳
41	5.3临床问题8	辽宁省人民医院/王胜勇	老年单纯收缩期高血压在联合中医药治疗时要避免体位性低血压及餐后低血压，同时避免舒张压过度下降	老年人血压波动大，单纯收缩期高血压多见，降压过程中容易出现体位性低血压及餐后低血压，而舒张压过度下降会影响冠脉供血，因此需要加强血压的监测	已采纳
42	5.3临床问题9	辽宁省人民医院/王胜勇	若无危险因素，主观意愿强烈要求用中药的患者，需要设置一个降压时限，比如4-6周，若经过该时间的治疗，患者血压控制仍然不理想，则需要及时联用西药降压	降压达标并不是无限期的。研究显示，早期降压达标（4周左右）能够更有效的降低终点事件，改善预后	已采纳
43	5.3临床问题10	辽宁省人民医院/王胜勇	联合中医药时减/撤西药需要格外慎重	总体来看，高血压是个进展性疾病，某一阶段的血压控制良好并不代表长期的血压控制，因此减/撤西药时需要密切监测血压，良好的评估。降压达标是准绳，而不是以减药、撤药为标准	已采纳
44	5.1治	辽宁省人	血压测量方	除了诊室血压外，需	已采纳

	疗原则	民医院/王胜勇	面的建议	要引入24小时动态血压和家庭自测血压，这有助于了解血压的具体情况和评估治疗的效果	
45	5.1治疗原则	辽宁省人民医院/王胜勇	2级高血压的降压达标时间	高血压需要在4-6周内将患者的血压控制在目标范围内。一方面血压早期达标有利于减少终点事件，另一方则有助于提升患者的治疗依从性	已采纳
46	总体的治疗方案	辽宁省人民医院/王胜勇	需要加入治疗过程中安全性、副反应方面的内容	任何一种治疗方案都是双刃剑，中医药也是一样。	已采纳
47	P4，4.2	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	建议适当增加高血压常见的证候	中医诊疗指南中有7个常见证候，如气血两虚证等，而本指南中未包括这些证候，是否应当要包括这些证候？	未采纳。已经专家讨论，气血两虚证所致高血压临床较少
48	P6,临床问题3	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见2、3推荐强度建议修改	推荐意见1、2证据级别均为C级，推荐强度均为强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
49	P7,临床问题4	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见1、2、3推荐强度建议修改	推荐意见1、2、3证据级别均为C级，推荐强度均为强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
50	P8,临床问题5	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见1推荐强度建议修改	推荐意见1证据级别为D级，推荐强度为强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
51	P9,推荐意见2	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见2推荐强度建议修改	推荐意见2证据级别为D级，推荐强度为强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
52	P9,临床问题6	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见的推荐强度建议修改	推荐意见的证据级别为B级，推荐强度为弱推荐，似乎不合理。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
53	P11，临床问题	湖南中医药大学中	推荐意见的推荐强度建	推荐意见的证据级别为C级，推荐强度	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上

	8	西医结合学院/邓常清	议修改	为强推荐，依据不充分。	述内容专家均审阅
54	P12，临床问题12	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见1的推荐强度建议修改	推荐意见1的证据级别为C级，推荐强度均强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
55	P14，临床问题12	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见2、3、4的推荐强度均建议修改	推荐意见2、3、4的证据级别均为C级，推荐强度均为强推荐，为什么？是否是根据专家共识？如果是以专家共识为依据的话，推荐意见5、6、7也应当为强推荐，这样才符合中医的辨证论治原则。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
56	P15，临床问题13	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见1的推荐强度建议修改	推荐意见1的证据级别为B级，推荐意见为弱推荐，不合理，建议改为推荐，针刺疗法是有明确的效应的。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
57	P16，推荐意见3（中药足浴疗法）	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见3的推荐强度建议修改	推荐意见3的证据级别为B级，推荐意见为弱推荐，不合理，建议改为推荐，中药足浴疗法是可以作为高血压的辅助治疗方法的。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
58	P16，推荐意见4（太极拳）	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见4的推荐强度建议修改（证据的依据）	推荐意见4的证据级别为C级，推荐意见为强推荐，为什么？太极拳对高血压是有较好的辅助治疗作用的，虽然证据级别较低，但这是目前的共识，根据共识，可以强推荐或推荐。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
59	3.1	广西国际壮医医院/姜益宏	来源：《国家基层高血压防治管理指南（2020版）》 建议更改为或增加： 来源：《中国高血压防治指南（2018年修订版）》	与3.2、4.1.1体例行文前后统一	已采纳

60	4.1.3	广西国际壮医医院/姜益宏	建议增加具体的心血管危险因素、靶器官损害、伴发临床损害表格，可参考《中国高血压防治指南（2018年修订版）》	作为高血压危险水平分层的重要依据	
61	4.2.5	广西国际壮医医院/姜益宏	头痛、胸痛、四肢麻木、心悸、口干、头晕 建议改为：头痛、头晕、胸痛、四肢麻木、心悸、口干； 诊断要点：头痛头重 应该为：头痛、头晕	主要症状靠前上下行文一致	已采纳
62	5.1	广西国际壮医医院/姜益宏	对于2级高血压患者，建议优先选择常规药物降压方案；但对于常规药物治疗基础上，存在未控制到目标血压、症状改善不明显、血压波动大等问题，可联合中医药疗法（中药汤剂、中成药和中医适宜技术等）协同治疗。另外，结合中医理论指导生活方式进行养生调摄，从而增强疗效，提高血压达标率。 建议更改为：对于2级高血压患者，建议结合中医理论指导生活方式进行治疗及养生调摄，如调整饮食结构、改善起居方式、导引运动等形式的基础上选择常规药物降压方案；但对于上述	生活方式治疗是所有高血压的基础治疗，优先选择常规药物降压方案有歧义；中医在改善生活方式治疗上有独特优势，应当发挥特色予以强调。	未采纳。《中国高血压防治指南(2018年修订版）》中真对级高血压已建议尽早联合用药

			治疗基础上，存在未控制到目标血压、症状改善不明显、血压波动大等问题，可联合中医药疗法（中药汤剂、中成药和中医适宜技术等）协同治疗。中西医结合治疗 2 级高血压仍需遵循中医理论，强调整体观念和辨证论治，注重个体化治疗。		
63	5.3	广西国际壮医医院/姜益宏	临床问题中对应的方药推荐是否加上对应的证型	保证理法方药一致性	部分采纳。有证据的均补充上
64	引用相关标准 1	广西国际壮医医院/姜益宏	《国家基层高血压防治管理指南（2020 版）》诊断标准建议更改或增加《中国高血压防治指南（2018 年修订版）》	两者诊断标准一致，保证前后行文一致	已采纳
65	4.1.3 危险分层	广西国际壮医医院/徐先增	应附有参考文献出处	重要内容应附有参考文献	已采纳
66	4.1.3 危险分层	广西国际壮医医院/徐先增	中/高危是否应该作为独立危险分层值得推敲	中/高危不是低危、中危、高危、很高危其中的一种	未采纳。指南中明确指出
67	5.3 临床问题	广西国际壮医医院/徐先增	一项纳入 4 篇 RCT 的 META 分析结果显示，应该有 4 篇参考文献	数量不对	已采纳
68	4.3	新疆医科大学附属中医医院/李鹏	临床问题 1：2 级高血压患者的常见证候类型，建议补充心肾阴虚型	高血压患者的常见中医证候类型存在一定的地域差异，心肾阴虚证是新疆地区高血压患者的常见证型之一	未采纳。专家投票得出
69	5.3.2	新疆自治区乌鲁木齐市中医	后者包括限盐、限酒、……加入控糖、低脂	高糖、高脂饮食是目前代谢综合征的主要原因	已采纳

		医院/邓德强	饮食		
70	5.3.3	新疆自治区乌鲁木齐市中医医院/邓德强	辨证加用中药汤剂(补益肝肾方)疑问	辨证为痰湿壅盛证、痰瘀互结证也用“补益肝肾方”？	已采纳
71	5.3.4	新疆自治区乌鲁木齐市中医医院/邓德强	辨证联用中药汤剂（半夏白术天麻汤）疑问	辨证为肝火亢逆证或阴阳两虚证也用“半夏白术天麻汤” ？	未采纳。仅列举有证据的内容
72	5.3	新疆自治区乌鲁木齐市中医医院/邓德强	临床问题条目下，序号错误，无问题 1		未采纳。问题 1 已按照体例进行编号
73	4.2	新疆自治区乌鲁木齐市中医医院/邓德强	症候诊断下建议给出建议方剂		已采纳
74	4.1.3	黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷	“根据血压水平、心血管危险因素、靶器官损害、临床并发症和糖尿病进行心血管风险，分为低危、中危、高危和很高危 4 个层次”，表述不当。建议：“根据血压水平、心血管危险因素、靶器官损害、临床并发症和糖尿病进行心血管危险分层，分为低危、中危、高危和很高危 4 个层次。”	人民卫生出版社第 9 版《内科学》中表述为“危险分层”。	已采纳
75	4.2	黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷	4.2 证候诊断中各症状之间是否“，”为宜，例如：4.2.1 肝郁气滞证 头晕、头痛、头胀、胸闷、胁	“十四五”《中医内科学》对症状描述中表述，各症状间用“，”。	未采纳。均可，行文格式统一即可

			胀或痛、情志抑郁或易怒、善太息、纳呆、痞满、腹部胀满，舌淡苔薄白、脉弦。表述为：头晕，头痛，头胀，胸闷，胁胀或痛，情志抑郁或易怒，善太息，纳呆，痞满，腹部胀满，舌淡苔薄白，脉弦。		
76	4.2	黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷	4.2 中各证型间见到相同症状是否统一表述更合适，例：4.2.1 肝郁气滞证头晕、头痛、头胀。4.2.2 肝火亢逆证头胀痛、头晕。是否统一表述为："头胀痛、头晕"。舌脉的描述是否更统一一些为好，例：舌脉表述统一格式"舌质（ ），苔( ),脉( )"。	表述统一，更具有严谨性。	未采纳。均可，行文格式统一即可
77	5.3 临床问题 7	黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷	"推荐意见 1：2 级高血压（很高危）患者中伴发高脂血症者"，表述为"推荐意见 1：2 级高血压（很高危）合并高脂血症患者"，是否更为得当？推荐意见 2 和推荐意见 3 的表述也推荐上面建议。	与下面的推荐说明的表述一致。	已采纳

78	5.3 临床问题14	黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷	推荐意见 1，中对针刺疗法的推荐“每周 2 至 3 次，4 周为一个疗程。”，每周 2 至 3 次的频率是否合适。	临床中针灸通常每周至少 5 至 6 次。	未采纳。不适合临床
79	5.3	黑龙江中医药大学附属第一医院/蒋宁	高血压合并肾脏疾病时，是否可以联用中药方剂。	临床问题 7 涉及该内容，但缺乏相关结论。	未采纳。缺乏相关证据，后续修订时补充
80	5.3	黑龙江中医药大学附属第一医院/蒋宁	如果高血压合并肾脏疾病时，可以联用中药方剂，具体有哪些，以及相关证据。	中国高血压防治指南 2018 年等指南对于高血压合并肾脏疾病患者的治疗和治疗目标均不同于普通患者。	未采纳。缺乏相关证据，后续修订时补充
81	5.3	黑龙江中医药大学附属第一医院/蒋宁	是否增加高血压合并代谢综合征相关内容	相关指南特殊人群高血压的处理一般包括糖尿病及代谢综合征相关内容。	未采纳。缺乏相关证据，后续修订时补充
82	5.3 临床问题11	长春中医药大学附属医院/王健	推荐意见 2 珍菊降压片应补充完善功能主治	治疗高血压的中成药种类繁多，因此每种中成药的药物组成、功能、适用人群（症状）的说明至关重要。	未采纳。已包括
83	5.3 临床问题12	长春中医药大学附属医院/王健	推荐意见 1 改为弱推荐	证据概要中只纳入 1 篇 RCT 研究，证据等级稍低。	未采纳。根据检索证据如实填写
84	5.3	长春中医药大学附属医院/王健	临床问题 3，推荐 1，“补益肝肾方”改为“调补肝肾”。	临床证型里肝郁、肝阳上亢。。。以实证居多，补益肝肾方主要用于虚证，感觉前后不一致。调补肝肾，虚实均兼顾。	未采纳。原文内容为“补益肝肾方”
	5.3	长春中医药大学附属医院/邓悦	第 11 页，“P=0.000”可统一为“P<0.001”	统计学行文习惯	已采纳
85	5.1	长春中医药大学附属医院/邓悦	第 5 页，“β”的字体与整体不统一	字体问题	已采纳
86	5.3	长春中医药大学附属医院/邓悦	中成药应注明详细的规格	明确中成药用量需要规格信息	已采纳

87		浙江中医药大学/季旭明	优化语言		已采纳
88	5.3	浙江中医药大学/季旭明	太极拳应注明每周的频次		已采纳
89	引言第一段	浙江中医药大学/季旭明	2002-2015年进行了三次全国高血压抽样调查研究，结果显示中国居民高血压患病率呈上升趋势。	对比2002-2015年间进行的三次全国性高血压抽样调查研究显示，中国居民高血压患病率呈逐渐上升趋势。	已采纳
90	引言第一段	山东第一医科大学第一附属医院/李欣然	控制2级高血压在高血压靶器官损害及并发症防治方面具有积极的价值。	因此，及时、有效地控制2级高血压对于改善高血压靶器官损害及防止并发症等方面均具有积极的价值。	已采纳
91	临床问题1	山东第一医科大学第一附属医院/李欣然	多空格	删掉空格	已采纳
92	3.2	山东第一医科大学第一附属医院/李欣然	多一个空格	删掉空格	已采纳
93	参考文献21、37、43、63	江苏省中医院/王永生	格式对齐		已采纳
94	编制说明	江苏省中医院/王永生	主审专家陈玉国教授需要补充		已采纳
95		江苏省中医院/王永生	疾病领域专家多句号		已采纳
96	定义临床问题	石家庄平安医院/黄怀鹏	参考文献5、6上标		已采纳
97		石家庄平安医院/黄怀鹏	正常血压正常高值血压范围中括号		已采纳
98		石家庄平安医院/黄怀鹏	调整一下附件七各种表格的格式，争取基本一致		已采纳
99		石家庄平安医院/黄怀鹏	修改编制说明中附件七标题	附件七标题与前面不一致	已采纳
100	4.2.1	石家庄白求恩国际	“头晕、头痛、头胀、胸闷、胁		已采纳

		和平医院/李庆华	胀或痛、情志抑郁或易怒、善太息、纳呆、痞满、腹部胀满，舌淡苔薄白、脉弦。”前增加“常见症状”		
101	5.1	石家庄白求恩国际和平医院/李庆华	“结合中医理论指导生活方式进行养生调摄，如调整饮食结构、改善起居方式等形式，从而增强疗效，提高血压达标率。”前增加“在生活方式指导的基础上”		已采纳
102	5.1	石家庄白求恩国际和平医院/李庆华	“常用降压药物包括钙通道阻滞剂、血管紧张素转化酶抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂、利尿剂和β受体阻滞剂五类，以及由上述药物组成的固定配比复方制剂。”是否增加诺欣妥		已采纳
103		南京中医药大学附属医院/常诚	“对于伴冠心病、糖尿病、心衰、肾功能不全、高脂血症等疾病的2级高血压（很高危）患者，是否联用中医药疗法协助降压？”是否修改相关疾病种类		已采纳
104		南京中医药大学附属医院/常诚	“血府逐瘀汤合涤痰汤具有行气化痰、活血化瘀”是否调整顺序		已采纳
105	4.3	南京中医药大学附属医院/常诚	“共检索144篇文献，其中流行病学调查141篇，专家共识3篇，结果显示：肝郁气滞证：20		已采纳

			篇”改为“141篇文献共20篇包含肝郁气滞证”		
106	3.1与3.2	首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊	高血压和2级高血压的定义建议参考同一个指南		已采纳
107	第6页	首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊	中医药疗法是个大的概念，里面写了中药汤药：辨证加用中药汤剂（补益肝肾方），合理配合中医适宜技术（针刺、耳穴贴压）以提高疗效、之后的每个问题，高血压的推荐意见，建议把文献的辩证分型写出来	前面有6型中不单是肝肾不足，或肝肾阴虚证，所以建议括号里面的补益肝肾方去掉。中医适宜技术建议加个“等”字，中医适宜技术有好多，比如足浴也可以辅助降压	部分采纳。涵盖的已修改
108	第13页	首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊	“推荐意见2：珍菊降压片可协助治疗2级高血压”。建议加上2级高血压的中医证型		未采纳。统一放在了功能主治中
109	第15页	首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊	临床问题13：中医适宜技术（针刺、耳穴贴压、足浴、太极拳）建议全文的中医适宜技术统一		未采纳。根据证据填写
110	第17页	首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊	诊疗流程图中里面的中药汤剂，中成药是和的关系还是或的关系		未采纳。根据证据填写
111	诊断	内蒙古自治区人民医院/斯琴高娃	需要添加高血压合并心理问题的中西医诊断	心理问题明显影响血压水平。	未采纳。根据指南填写
112	治疗	内蒙古自治区人民医院/斯琴高娃	1.高血压合并心理问题的中西医诊断明确时，除	● 心理治疗包括认知行为治疗、正念减压放松治疗、运动治疗、	未采纳。根据指南填写

			了中西医药物治疗外，也推荐中西医心理治疗。	音乐治疗等明显减低血压水平。 ● 中医也有情志治疗等等。	
113		内蒙古自治区人民医院/斯琴高娃	2.高血压的营养指导与治疗也可以降低血压。	比如高盐高脂肪饮食及肥胖都会影响血压。	部分采纳。根据指南填写
114		内蒙古自治区人民医院/斯琴高娃	3.高血压是否合并 OSA 病因治疗	OSA 也影响血压	未采纳。根据指南填写
115	13 页	内蒙古医科大学附属医院/韩额尔德木图	珍菊降压片等是否谨慎选择呢？	成分中有可乐定,氢氯噻嗪等	未采纳。根据指南填写
116	17 页	内蒙古医科大学附属医院/韩额尔德木图	诊治流程图！	可能个人的理解问题，总觉得有进一步完善的空间	未采纳。根据指南填写
117	13 页	内蒙古医科大学附属医院/韩额尔德木图	怎么提高患者的依从性，减低经济负担？	我是蒙医学临床医生，临床中应用过松龄血脉康，从患者角度考虑实属不易，口服次数多以及经济负担也不小。	未采纳。根据证据填写
118	无	空军军医大学第一附属医院/刘海涛	无	内容详实，证据可靠	
119	临床问题 1	应急总医院/常富业	无	临床来看，基本上分为该六型。	已采纳
120	临床问题 2	应急总医院/常富业	无	中医养生调摄等方法以协助降压，对于个体的高血压管理不可或缺。所谓控制血压就是生活，作为个体生活的一部分，养生调摄非常重要。	已采纳
121	临床问题 3	应急总医院/常富业	无	2 级高血压患者，联用中医药疗法，有助于消除各种因素带来的血压不稳定，有助于平稳降压，减缓或消除血压波动带来的各种症状和体征。	
122	临床问题 4	应急总医院/常富业	无	2 级高血压患者，往往在血压波动时期，出现头晕、头痛等不适症状，在常规西医治疗基础上， 联用中医药疗法可	

				有效缓解患者不适症状。	
123	临床问题 5	应急总医院/常富业	无	对于 2 级高血压患者血压波动大者，在常规西药控制血压的基础上，联合中医药疗法能有效地解除各种病因带来的血压波动，缓解患者的各种不适症状。	
124	临床问题 6	应急总医院/常富业	无	对于 2 级高血压（高危）患者，联用中医药疗法能有效防治靶器官损伤。	
125	临床问题 7	应急总医院/常富业	无	对于伴冠心病、糖尿病、心衰、肾功能不全、高脂血症等疾病的 2 级高血 压（很高危）患者，可以联用中医药疗法协助降压，同时能有效缓解或消除所伴有疾病的多种症状。	
126	临床问题 8	应急总医院/常富业	无	2 级单纯收缩期高血压患者，联合中医药疗法有助于协助降压，改善动脉硬化的临床症状，延缓靶器官损伤的病理过程。	
127	临床问题 9	应急总医院/常富业	无	对于中医药疗法意愿强烈的 2 级高血压患者，可联用中医药疗法以协助控制血压，不仅增强患者控制高血压的信心，同时有助于提高控制高血压各种手段的依从性，提高西药降压的效果。	
128	临床问题 10	应急总医院/常富业	无	对于 2 级高血压患者，与常规治疗相比，联合中医药有助于缩短血压控制达标的时间，有助于尽快缓解或消除高血压的症状和体征，有助于消除长期应用西药所带来的用药恐惧，有助于减少西药的用量或用药种类。	
129	临床问题 11	应急总医院/常富业	无	中成药适宜干预 2 级高血压患者，有助于减少西药降压药物的用量和种类，而且依从性高。	

130	临床问题 12	应急总医院/常富业	无	在辨证施治的基础上，中医经典方剂（柴胡疏肝散、天麻钩藤饮、镇肝熄风汤、半夏白术天麻 汤、血府逐瘀汤合涤痰汤、六味地黄丸、肾气丸）同样适宜干预 2 级高血压患者，具有整体调节、依从性高，消除临床症状或体征快，减缓并发症发生的特点。	
131	临床问题 13	应急总医院/常富业	无	在西药控制血压的基础上，中医适宜技术（针刺、耳穴贴压、足浴、太极拳）适宜干预 2 级高血压患者，有助于控制血压的自我管理，平稳降压，避免血压的波动，提高降压效果。	
132		山东宏济堂制药集团股份有限公司/孟兆青	无意见		
133	/	浙江中医药大学/万海同	无	该标准证据充分，制定合理，符合临床 2 级高血压诊疗需要。	

（十一）送审

2022年9月30日送审至中华中医药学会。并于2023年1月5日召开中华中医药学会团体标准/专家共识审查会，以满票通过发布审查。

四、与国内外同类指南的对比和最新指南采用情况

（一）描述国内外是否有已发布且正在实施中的同领域指南？本指南与其相比，有什么区别？

国内最权威的治疗高血压的指南为中华医学会发布的《中国高血压防治指南》2，最新版为 018 年修订版。该指南参考了世界卫生组织、中华医学会指南制订流程,对指南重要内容、证据级别及推荐类型进行了评估。在借鉴国际先进经验的基础上,结合我国高血压防治工作实践,充分应用中国证据,形成具有中国特色的高血压预防干预、诊断评估、分类分层、治疗管理指南。

在中医方面，由中华中医药学会发布的《高血压中医诊疗专家共识》，最新版为 2019 年版。该共识参考了《中国高血压防治指南》及《2018 ESC/ESH

Guidelines for the management of arterial hypertension》，以传统中医辨证论治与方证辨证理论为指导，在梳理历代高血压文献的基础上，结合现代循证医学理念，对高血压的关键病机、证候特点、经典名方辨证用药规律进行了总结讨论。

本指南与其相较，有共性的基础，但在传统辩证的基础上以及在现代医学基础之上，更加突出了中西医结合治疗高血压的优势点，强调中西医结合诊疗对高血压病的优化管理和治疗措施，更加体现中西医结合的优势和特色。

（二）是否引用相关指南？引用的内容是什么？

本共识的部分内容借鉴和引用了 2018 年《中国高血压防治指南》，其中诊断标准与其保持高度一致；其次五大类降压药物的推荐；最后对高血压患者的靶目标管理、合并靶器官损害、危险因素的控制以及生活方式的干预也有适当的借鉴和引用。

五、与现行强制性国家标准或政策法规的关系

本项目工作组研究形成的《2 级高血压中西医结合诊疗指南》与现行法律、法规和强制性标准没有冲突，并且在编制过程中严格遵循已有的国际、国内标准，使文本内容符合规范，言之有据。

六、代表性分歧意见的处理经过和依据

本共识制订过程中，无重大分歧意见。

七、宣传、贯彻指南和后效评价指南的要求和措施

（一）宣传、贯彻指南的措施

1. 指南的实施单位

由国家中医药管理局统一组织行业内的推广和贯彻实施工作；共识的实施单位初步定在：山东中医药大学附属医院、河南中医药大学第一附属医院、济南市中医医院、江苏省中医院、中国中医科学院广安门医院、烟台市中医院、淄博市中医医院。

2. 其他宣传、贯彻本指南的措施

（1）借助中医药学会等多个平台，利用传统和新媒体进行报导

该诊疗方案公示后，对该诊疗方案进行发布。同时，请报刊媒体及新媒体对该诊疗方案的编制情况及意义进行报导宣传。此外，还可将该诊疗方案上传至网络，方便有需求者随时下载使用，以进一步促进其在全国范围内更快更好地的实

施应用。

（2）依托中华中医药学会、山东省中医药学会推广带动

在该团体标准被公示后，依托中华中医药学会、山东省中医药学会的相关学术会议上发放纸质版及电子版团体标准，并进与该诊疗方案相关的专题学术报告。

（3）依托本技术规范发起单位--医疗机构推广带动

山东中医药大学附属医院为国家高血压临床研究基地，同时，包括天津中医药大学在内的多家单位作为本项目的发起单位，均为三级甲等中医医院。在该团体标准公示后，将率先响应该团体标准，以带动全国中医医疗机构、综合医疗机构等全面实施。每年应用试点围绕该团体标准举办多次专题学术活动或参观交流活动。

（4）依托发起人推广带动

本项目发起人在参加或组织相关领域的学术会议、国家级或省级中医药学会分会年会时，将采用主题报告、会议交流等多种形式，积极分享和推广将该团体标准。

（5）发表相关的学术论文

由发起单位组织人员，积极撰写与该团体标准有关的学术论文，在专业杂志发表，提高其影响力和推广效果。

（二）指南的用户评价

拟在本共识发布后半年内完成指南的用户评价及用户评价的报告。

（三）指南的修订

本共识计划5年后进行更新，更新方案主要涉及干预措施的种类、证据等级以及推荐强度，对本共识进一步补充、修订、更新。

八、废止现行有关指南的建议

无。

九、相关附录

（一）立项公告（即附录1）

中华中医药学会

中华中医药学会团体标准

立项公告

China Association of Chinese Medicine

Announcement for Standards

中华中医药学会批准《23 项中西医结合诊疗方案》（20220401～23-BZ-CACM）立项，现予公告。

The T/CACM standard for 23 diagnosis and treatment protocol of integrated traditional Chinese and western medicine (20220401～23-BZ-CACM) was initiated by the China Association of Chinese Medicine, and now it is effective.

附件：23 项中西医结合诊疗方案团体标准项目信息汇总表

中华中医药学会

China Association of Chinese Medicine

2022 年 4 月 11 日

附件：23 项中西医结合诊疗方案团体标准项目信息汇总表

序号	立项编号	共识名称	承担单位	牵头专家	立项时间
1	20220401-BZ-CACM	化疗所致周围神经病理性疼痛中西医结合诊疗方案	中日友好医院	贾立群	2022 年 4 月 11 日
2	20220402-BZ-CACM	2 级高血压中西医结合诊疗方案	山东中医药大学附属医院	李运伦	
3	20220403-BZ-CACM	高血压脑出血中西医结合诊疗方案	长春中医药大学附属医院	王健	
4	20220404-BZ-CACM	癫痫中西医结合诊疗方案	浙江省中医院	郑国庆	
5	20220405-BZ-CACM	2 型糖尿病中西医结合诊疗方案	中国中医科学院广安门医院	仝小林	
6	20220406-BZ-CACM	特发性膜性肾病中西医结合诊疗方案	广东省中医院	包崑	

序号	立项编号	共识名称	承担单位	牵头专家	立项时间
7	20220407-BZ-CACM	子宫内膜异位症中西医结合诊疗方案	中国中医科学院广安门医院	赵瑞华	2022 年 4 月 11 日
8	20220408-BZ-CACM	子宫腺肌病中西医结合诊疗方案	中国中医科学院广安门医院	赵瑞华	
9	20220409-BZ-CACM	复发性流产中西医结合诊疗方案	河北省中医院	杜惠兰	
10	20220410-BZ-CACM	卵巢早衰中西医结合诊疗方案	河北省中医院	杜惠兰	
11	20220411-BZ-CACM	先兆流产中西医结合诊疗方案	黑龙江中医药大学附属第一医院	冯晓玲	
12	20220412-BZ-CACM	围绝经期综合征中西医结合诊疗方案	广东省中医院	王小云	
13	20220413-BZ-CACM	儿童流行性感冒中西医结合诊疗方案	辽宁中医药大学附属医院	王雪峰	

序号	立项编号	共识名称	承担单位	牵头专家	立项时间
14	20220414-BZ-CACM	儿童功能性消化不良中西医结合诊疗方案	辽宁中医药大学附属医院	王雪峰	2022 年 4 月 11 日
15	20220415-BZ-CACM	儿童变应性鼻炎中西医结合诊疗方案	江苏省中医院	赵霞	
16	20220416-BZ-CACM	儿童心肌炎中西医结合诊疗方案	天津中医药大学第一附属医院	胡思源	
17	20220417-BZ-CACM	幼年特发性关节炎中西医结合诊疗方案	首都医科大学北京儿童医院	胡艳	
18	20220418-BZ-CACM	重症急性胰腺炎中西医结合诊疗方案	天津市南开医院	崔云峰 王西墨	
19	20220419-BZ-CACM	重型/危重型新型冠状病毒肺炎中西医结合诊疗方案	中国中医科学院广安门医院	仝小林	
20	20220420-BZ-CACM	膝骨关节炎中西医结合诊疗方案	广东省中医院 广东省第二中医院	杨伟毅 刘军	

序号	立项编号	共识名称	承担单位	牵头专家	立项时间
21	20220421-BZ-CACM	肩袖损伤中西医结合诊疗方案	广东省第二中医院	刘军	2022 年 4 月 11 日
22	20220422-BZ-CACM	痛风及高尿酸血症中西医结合诊疗方案	天津中医药大学第一附属医院	刘维	
23	20220423-BZ-CACM	寻常型银屑病中西医结合诊疗方案	首都医科大学附属北京中医医院	周冬梅	

（二）调研问卷及结论（即附件 2）

第一轮： 2 级高血压中西医结合诊疗专家共识临床问题调研

第 1 题　您的性别　[单选题]

选项	小计	比例
男	53	55.21%
女	43	44.79%
本题有效填写人次	96	

第 2 题　您的学历　[单选题]

选项	小计	比例
专科	1	1.04%
本科	40	41.67%
硕士	38	39.58%
博士	17	17.71%
本题有效填写人次	96	

第 3 题　您所在的城市　[填空题]

第 4 题　您所在医院类型　[单选题]

选项	小计	比例
综合性医院	37	38.54%
中医医院	59	61.46%
本题有效填写人次	96	

第 5 题　您所在医院级别　[单选题]

选项	小计	比例

三级医院	80	83.33%
二级医院	15	15.63%
基层医院	1	1.04%
本题有效填写人次	96	

第 6 题　您所在科室　[填空题]

第 7 题　您的专业　[单选题]

选项	小计	比例
中医	47	48.96%
西医	30	31.25%
中西医结合	19	19.79%
本题有效填写人次	96	

第 8 题　从事本专业年限　[单选题]

选项	小计	比例
<3 年	13	13.54%
3-5 年	12	12.5%
6-10 年	13	13.54%
10-19 年	36	37.5%
20 年以上	22	22.92%
本题有效填写人次	96	

第 9 题　职称　[单选题]

选项	小计	比例
主任医师	23	23.96%
副主任医师	30	31.25%

主治医师	43	44.79%
本题有效填写人次	96	

第 10 题　对于基于中西医结合理念干预 2 级高血压，您最常应用或最关注哪些方面？ [多选题]

选项	小计	比例
术语和定义	33	34.38%
病因病机	48	50%
中医辨证	55	57.29%
中西医结合治疗方案	82	85.42%
中西医结合的治疗时机与策略优化	72	75%
其他（请具体描述）	2	2.08%
本题有效填写人次	96	

第 11 题　您认为什么类型的 2 级高血压患者适合中西医结合干预？ [多选题]

选项	小计	比例
首诊 2 级高血压患者	42	43.75%
化药干预后效果不佳 2 级高血压患者	69	71.88%
存在口服药物不耐受的 2 级高血压患者	75	78.13%
个人意愿较为强烈的 2 级高血压患者	64	66.67%
所有患者	27	28.13%
所有患者均不可应用	4	4.17%
其他（请具体描述）	0	0%
本题有效填写人次	96	

第 12 题　对于 2 级高血压患者的危险分层，哪些患者可应用中西医结合诊疗？ [多选题]

选项	小计	比例
中危	84	87.5%
高危	79	82.29%
很高危	47	48.96%
本题有效填写人次	96	

第 13 题　2 级高血压患者的常见证候类型是否可以归结为肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证？ [单选题]

选项	小计	比例
是	93	96.88%
否（请具体描述）	3	3.13%
本题有效填写人次	96	

第 14 题　您在临床上可能用到的针对某个证型的中药汤剂有哪些？ [多选题]

选项	小计	比例
肝火亢逆----龙胆泻肝汤	78	81.25%
肝火亢逆----其他（请具体描述）	8	8.33%
阴虚阳亢---天麻钩藤饮	78	81.25%
阴虚阳亢----其他（请具体描述）	5	5.21%
痰湿壅盛----半夏白术天麻汤	78	81.25%
痰湿壅盛----其他（请具体描述）	1	1.04%
痰瘀互结----大瓜蒌散合涤痰汤	50	52.08%
痰瘀互结----其他（请具体描述）	1	1.04%
阴阳两虚（偏阴虚）----知柏地黄丸	59	61.46%
阴阳两虚（偏阴虚）----其他（请具体描述）	2	2.08%
阴阳两虚（偏阳虚）----济生肾气丸	57	59.38%

阴阳两虚（偏阳虚）----其他（请具体描述）	2	2.08%
本题有效填写人次	96	

第 15 题　中成药是否适宜干预 2 级高血压患者？　[单选题]

选项	小计	比例
是	92	95.83%
否	4	4.17%
本题有效填写人次	96	

第 16 题　您在临床上可能用到的治疗 2 级高血压的中成药有哪些？　[多选题]

选项	小计	比例
松龄血脉康胶囊	47	48.96%
牛黄降压丸	49	51.04%
珍菊降压片	71	73.96%
都无法应用	5	5.21%
本题有效填写人次	96	

第 17 题　请结合您的临床经验，除上述中成药外您认为还有哪些中成药可用于 2 级高血压的治疗？　[填空题]

第 18 题　您认为中医干预 2 级高血压患者的措施应包括？　[多选题]

选项	小计	比例
中药汤剂	84	87.5%
中成药	86	89.58%
针刺	55	57.29%
推拿	39	40.63%
耳穴贴压	67	69.79%

传统功法治疗（太极拳、八段锦、五禽戏等）	56	58.33%
其他（请具体描述）	3	3.13%
本题有效填写人次	96	

第 19 题　您认为针对中西医结合的治疗时机与策略优化应包括哪些内容？ [多选题]

选项	小计	比例
对于首次就诊时患者西医诊疗盲区的深化处理	80	83.33%
对于血压达标后患者西医剩余风险的优化解决	84	87.5%
对于血压未达标时患者潜在风险的强化管控	85	88.54%
其他（请具体描述）	2	2.08%
本题有效填写人次	96	

第 20 题　您认为中西医结合治疗法治疗 2 级高血压的干预时机为何时？ [多选题]

选项	小计	比例
初次确诊后便可应用	67	69.79%
证实化药干预疗效不佳时	68	70.83%
和化药同步使用	65	67.71%
证实生活方式调整收效不佳时	64	66.67%
随时都可应用	38	39.58%
所有患者均不可应用	5	5.21%
本题有效填写人次	96	

第 21 题　对于首诊诊为 2 级高血压的患者，可否运用中医养生调摄来增强生活方式指导对血压的疗效？ [单选题]

选项	小计	比例
是	93	96.88%
否	3	3.13%
本题有效填写人次	96	

第 22 题　对于首诊诊为 2 级高血压的患者，可否运用中医药疗法协助控制血压？ [单选题]

选项	小计	比例
是	96	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	96	

第 23 题　对于中医疗法意愿强烈的诊为 2 级高血压首诊患者，如何控制患者血压？ [多选题]

选项	小计	比例
化药	67	69.79%
中药汤剂	80	83.33%
中成药	81	84.38%
针刺	45	46.88%
推拿	38	39.58%
耳穴贴压	58	60.42%
传统功法治疗（太极拳、八段锦、五禽戏等）	53	55.21%
养生调摄	61	63.54%
其他（请具体描述）	0	0%
本题有效填写人次	96	

第 24 题　对于化药控制后血压达标但仍存在症状的 2 级高血压患者，可否运用中医药疗法改善患者症状？　[单选题]

选项	小计	比例
是	96	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	96	

第 25 题　对于化药控制后存在副作用或者禁忌的患者 2 级高血压患者，可否采用中药增效减毒？　[单选题]

选项	小计	比例
是	93	96.88%
否	3	3.13%
本题有效填写人次	96	

第 26 题　在改善生活方式的基础上，应用多种降压药物，治疗后血压达标且有减药需求的 2 级高血压患者如何控制患者血压？　[多选题]

选项	小计	比例
减少化药种类	71	73.96%
减少化药用量	73	76.04%
中药汤剂	69	71.88%
中成药	60	62.5%
针刺	44	45.83%
推拿	34	35.42%
耳穴贴压	52	54.17%
传统功法治疗（太极拳、八段锦、五禽戏等）	45	46.88%
其他（请具体描述）	2	2.08%

本题有效填写人次	96	

第 27 题　对于化药控制后血压不稳定（波动大）且自我管理较差的 2 级高血压患者，可否加用中药和缓降压？ [单选题]

选项	小计	比例
是	94	97.92%
否	2	2.08%
本题有效填写人次	96	

第 28 题　在改善生活方式的基础上，血压仍高于 160/100mmHg 的 2 级高血压患者如何控制患者血压？ [多选题]

选项	小计	比例
化药	80	83.33%
中药汤剂	82	85.42%
中成药	74	77.08%
针刺	45	46.88%
推拿	36	37.5%
耳穴贴压	57	59.38%
传统功法治疗（太极拳、八段锦、五禽戏等）	47	48.96%
其他（请具体描述）	3	3.13%
本题有效填写人次	96	

第 29 题　在改善生活方式的基础上，应用一类降压药物，血压仍高于 160/100mmHg 的 2 级高血压患者如何控制患者血压？ [多选题]

选项	小计	比例
增加化药种类	69	71.88%

增加化药用量	52	54.17%
中药汤剂	77	80.21%
中成药	75	78.13%
针刺	52	54.17%
推拿	43	44.79%
耳穴贴压	59	61.46%
传统功法治疗（太极拳、八段锦、五禽戏等）	52	54.17%
其他（请具体描述）	0	0%
本题有效填写人次	96	

第 30 题　在改善生活方式的基础上，应用 2 类或 2 类以上降压药物，血压仍高于 160/100mmHg 的 2 级高血压患者如何控制患者血压？ [多选题]

选项	小计	比例
增加化药用量	64	66.67%
中药汤剂	77	80.21%
中成药	80	83.33%
针刺	56	58.33%
推拿	47	48.96%
耳穴贴压	65	67.71%
传统功法治疗（太极拳、八段锦、五禽戏等）	56	58.33%
其他（请具体描述）	2	2.08%
本题有效填写人次	96	

第二轮：2 级高血压中西医结合诊疗专家共识临床问题调研

您的性别：　[单选题]

选项	小计	比例
男	24	57.14%
女	18	42.86%
本题有效填写人次	42	

您的学历　[单选题]

选项	小计	比例
专科	0	0%
本科	9	21.43%
硕士	22	52.38%
博士	11	26.19%
本题有效填写人次	42	

您所在的城市　[填空题]

您所在医院类型　[单选题]

选项	小计	比例
综合性医院	19	45.24%
中医医院	23	54.76%
本题有效填写人次	42	

您所在医院级别　[单选题]

选项	小计	比例
三级医院	37	88.1%
二级医院	5	11.9%

基层医院	0	0%
本题有效填写人次	42	

您所在科室 [填空题]

您的专业 [单选题]

选项	小计	比例
中医	17	40.48%
西医	17	40.48%
中西医结合	8	19.05%
本题有效填写人次	42	

从事本专业年限 [单选题]

选项	小计	比例
<3 年	3	7.14%
3-5 年	5	11.9%
6-10 年	14	33.33%
10-19 年	18	42.86%
20 年以上	2	4.76%
本题有效填写人次	42	

职称 [单选题]

选项	小计	比例
主任医师	4	9.52%
副主任医师	21	50%
主治医师	12	28.57%
住院医师	5	11.9%

本题有效填写人次	42	

问卷填写说明：
请您根据临床经验，对相关调查问题进行评价，分值 1-5 分，1 分表示最不认可（疗效很不满意），5 分表示最认可（疗效很满意）。

您认为中西医结合干预 2 级高血压患者疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	1	2.38%
3 分	6	14.29%
4 分	9	21.43%
5 分	26	61.9%
本题有效填写人次	42	

您认为在患者首次就诊时中西医结合深化处理西医诊疗盲区对 2 级高血压患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	1	2.38%
3 分	7	16.67%
4 分	9	21.43%
5 分	25	59.52%
本题有效填写人次	42	

您认为在患者血压达标后中西医结合优化解决西医剩余风险对 2 级高血压患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例

1 分	0	0%
2 分	1	2.38%
3 分	9	21.43%
4 分	6	14.29%
5 分	26	61.9%
本题有效填写人次	42	

您认为在患者血压未达标时中西医结合强化管控患者潜在风险对 2 级高血压患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	0	0%
3 分	8	19.05%
4 分	10	23.81%
5 分	23	54.76%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者首诊时，应用中西医结合干预疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	1	2.38%
3 分	3	7.14%
4 分	11	26.19%
5 分	26	61.9%
本题有效填写人次	42	

您认为对于首诊诊为 2 级高血压的患者,运用中医养生调摄来增强生活方式指导疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	1	2.38%
3 分	5	11.9%
4 分	10	23.81%
5 分	26	61.9%
本题有效填写人次	42	

您认为对于首诊诊为 2 级高血压的患者，运用中医药疗法协助控制血压疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	2	4.76%
3 分	8	19.05%
4 分	4	9.52%
5 分	28	66.67%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者证实生活方式调整收效不佳时,应用中西医结合干预疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	0	0%
3 分	4	9.52%
4 分	12	28.57%

5 分	25	59.52%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者使用化药时，同步应用中西医结合干预疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	1	2.38%
3 分	5	11.9%
4 分	5	11.9%
5 分	31	73.81%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者化药治疗效果不佳时，应用中西医结合干预疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	0	0%
3 分	4	9.52%
4 分	9	21.43%
5 分	28	66.67%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者存在口服药物不耐受时，应用中西医结合干预疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%

2 分	0	0%
3 分	3	7.14%
4 分	10	23.81%
5 分	28	66.67%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者人应用意愿较为强烈时，应用中西医结合干预疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	1	2.38%
3 分	3	7.14%
4 分	12	28.57%
5 分	26	61.9%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者在改善生活方式的基础上应用多种降压药物，治疗后血压达标且有减药需求，应用中西医结合干预疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	0	0%
3 分	3	7.14%
4 分	13	30.95%
5 分	25	59.52%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者化药控制后血压不稳定（波动大）且自我管理较差，加用中药和缓降压疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	2	4.76%
3 分	6	14.29%
4 分	11	26.19%
5 分	23	54.76%
本题有效填写人次	42	

您认为中西医结合干预危险分层为中、高危的 2 级高血压患者疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	1	2.38%
3 分	4	9.52%
4 分	11	26.19%
5 分	25	59.52%
本题有效填写人次	42	

您认为中西医结合干预危险分层为很高危的 2 级高血压患者疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	1	2.38%
3 分	9	21.43%
4 分	8	19.05%
5 分	24	57.14%
本题有效填写人次	42	

您认为在 2 级高血压患者应用化药血压达标后，仍存在症状时运用中医药疗法改善患者症状疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	1	2.38%
3 分	4	9.52%
4 分	7	16.67%
5 分	30	71.43%
本题有效填写人次	42	

您认为在 2 级高血压患者应用化药后存在药物副作用或者用药禁忌时，采用中药增效减毒对患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	0	0%
3 分	6	14.29%
4 分	9	21.43%
5 分	26	61.9%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者改善生活方式的基础上血压仍高于 160/100mmHg 时，中西医结合干预疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	0	0%
3 分	6	14.29%

4 分	9	21.43%
5 分	26	61.9%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者改善生活方式的基础上应用一类降压药物，血压仍高于 160/100mmHg 时，中西医结合干预疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	0	0%
3 分	5	11.9%
4 分	12	28.57%
5 分	24	57.14%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者改善生活方式的基础上，应用 2 类或 2 类以上降压药物，血压仍高于 160/100mmHg 时，中西医结合干预疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	0	0%
3 分	11	26.19%
4 分	5	11.9%
5 分	25	59.52%
本题有效填写人次	42	

您认为中药汤药辨证论治干预 2 级高血压患者疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%

2 分	0	0%
3 分	8	19.05%
4 分	9	21.43%
5 分	24	57.14%
本题有效填写人次	42	

您认为中成药干预 2 级高血压患者疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	2	4.76%
2 分	2	4.76%
3 分	7	16.67%
4 分	8	19.05%
5 分	23	54.76%
本题有效填写人次	42	

您认为松龄血脉康干预 2 级高血压患者疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	2	4.76%
2 分	3	7.14%
3 分	9	21.43%
4 分	9	21.43%
5 分	19	45.24%
本题有效填写人次	42	

您认为珍菊降压片干预 2 级高血压患者疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例

1 分	4	9.52%
2 分	1	2.38%
3 分	11	26.19%
4 分	10	23.81%
5 分	16	38.1%
本题有效填写人次	42	

您认为牛黄降压丸干预 2 级高血压患者疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	4	9.52%
2 分	1	2.38%
3 分	10	23.81%
4 分	10	23.81%
5 分	17	40.48%
本题有效填写人次	42	

您认为哪些中成药适宜干预 2 级高血压？ [填空题]

您认为应用针刺降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状对患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	4	9.52%
3 分	10	23.81%
4 分	9	21.43%
5 分	19	45.24%
本题有效填写人次	42	

您认为应用推拿降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状对患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	5	11.9%
3 分	11	26.19%
4 分	12	28.57%
5 分	14	33.33%
本题有效填写人次	42	

您认为应用耳穴压豆降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状对患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	7	16.67%
3 分	9	21.43%
4 分	11	26.19%
5 分	15	35.71%
本题有效填写人次	42	

您认为应用中药足浴降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状对患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	6	14.29%
3 分	11	26.19%
4 分	7	16.67%

5 分	17	40.48%
本题有效填写人次	42	

您认为患者应用传统运动方式降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状对患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	0	0%
3 分	13	30.95%
4 分	9	21.43%
5 分	19	45.24%
本题有效填写人次	42	

您认为患者应用极拳降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状对患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%
2 分	1	2.38%
3 分	13	30.95%
4 分	8	19.05%
5 分	19	45.24%
本题有效填写人次	42	

您认为患者应用八段锦降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状对患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	1	2.38%

2 分	1	2.38%
3 分	12	28.57%
4 分	7	16.67%
5 分	21	50%
本题有效填写人次	42	

您认为患者应用五禽戏降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状对患者帮助如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	2	4.76%
3 分	11	26.19%
4 分	9	21.43%
5 分	20	47.62%
本题有效填写人次	42	

如果您是中医医师、中西医结合医师，或能应用中医药疗法开展临床诊治的西医医师，请继续回答下列问题 [单选题]

选项	小计	比例
中医医师、中西医结合医师，或能应用中医药疗法开展临床诊治的西医医师	26	61.9%
西医医师	16	38.1%
本题有效填写人次	42	

您认为 2 级高血压患者证候类型是否可以归结为肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%

2 分	0	0%
3 分	2	7.69%
4 分	4	15.38%
5 分	20	76.92%
本题有效填写人次	26	

您认为龙胆泻肝汤干预 2 级高血压患者（肝火亢逆证）疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	0	0%
3 分	5	19.23%
4 分	7	26.92%
5 分	14	53.85%
本题有效填写人次	26	

您认为天麻钩藤饮干预 2 级高血压患者（肝火亢逆证）疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	0	0%
3 分	4	15.38%
4 分	6	23.08%
5 分	16	61.54%
本题有效填写人次	26	

您认为羚角钩藤汤干预 2 级高血压患者（肝火亢逆证）疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例

1 分	0	0%
2 分	0	0%
3 分	4	15.38%
4 分	5	19.23%
5 分	17	65.38%
本题有效填写人次	26	

您认为天麻钩藤饮干预 2 级高血压患者（阴虚阳亢证）疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	1	3.85%
3 分	5	19.23%
4 分	6	23.08%
5 分	14	53.85%
本题有效填写人次	26	

您认为镇肝熄风汤干预 2 级高血压患者（阴虚阳亢证）疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	0	0%
3 分	4	15.38%
4 分	3	11.54%
5 分	19	73.08%
本题有效填写人次	26	

您认为半夏白术天麻汤干预 2 级高血压患者（痰湿壅盛证）疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	2	7.69%
3 分	4	15.38%
4 分	2	7.69%
5 分	18	69.23%
本题有效填写人次	26	

您认为大瓜蒌散合涤痰汤干预 2 级高血压患者（痰瘀互结证）疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	2	7.69%
3 分	4	15.38%
4 分	6	23.08%
5 分	14	53.85%
本题有效填写人次	26	

您认为血府逐瘀汤合涤痰汤干预 2 级高血压患者（痰瘀互结证）疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	2	7.69%
3 分	3	11.54%
4 分	3	11.54%
5 分	18	69.23%
本题有效填写人次	26	

您认为知柏地黄丸干预 2 级高血压患者(阴阳两虚证-偏阴虚)疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	0	0%
3 分	6	23.08%
4 分	5	19.23%
5 分	15	57.69%
本题有效填写人次	26	

您认为六味地黄丸干预 2 级高血压患者(阴阳两虚证-偏阴虚)疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	2	7.69%
3 分	4	15.38%
4 分	2	7.69%
5 分	18	69.23%
本题有效填写人次	26	

您认为济生肾气丸干预 2 级高血压患者(阴阳两虚证-偏阳虚)疗效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
1 分	0	0%
2 分	2	7.69%
3 分	4	15.38%

4 分	2	7.69%
5 分	18	69.23%
本题有效填写人次	26	

（三）历次会议纪要

1.《2 级高血压中西医结合诊疗专家共识》第一轮专家会会议纪要

1. 时　　间：2022 年 7 月 2 日　14:30-17:00

2. 地　　点：驻地（腾讯视频会议）

3. 参会人员：山东中医药大学附属医院　　李运伦、薛一涛、焦华琛、张磊

河南中医药大学第一附属医院　　朱明军

中国中医科学院西苑医院　　徐浩

北京中医药大学东方医院　　赵海滨、贺立娟

中国中医科学院广安门医院　　李军

安徽中医药大学第一附属医院　　戴小华

山东大学齐鲁医院　　卜培莉

广东省中医院　　陈伯钧

上海中医药大学龙华医院　　王佑华

天津中医药大学　　翟静波

天津中医药大学第一附属医院　　樊官伟

南京中医药大学附属医院　　王永生

北方交通医院　　周雪忠

成都中医药大学大一附属医院　　谢文

山东第一医科大学第一附属医院　　李晓鲁、张玉娇

海军军医大学长海医院　　岳小强

济南市中医医院　　张红星

山东中医药大学　　杨佃会

中华中医药学会　　苏祥飞

会议纪要

1.李运伦教授介绍参会专家与相关领导

2.苏祥飞主任作中成药临床应用专家共识相关内容介绍

3.李运伦教授作项目背景及前期工作成果介绍

4.苏祥飞主任标准问题确定介绍

5.李运伦教授介绍临床问题条目，优化原始问题清单

原始问题如下：

1.2级高血压患者的常见证候类型可以归结为肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证吗？

2.天麻钩藤饮适宜干预2级高血压肝火亢逆证患者吗？

3.镇肝息风汤适宜干预2级高血压阴虚阳亢证患者吗？

4.半夏白术天麻汤适宜干预2级高血压痰湿壅盛证患者吗？

5.血府逐瘀汤合涤痰汤适宜干预2级高血压痰瘀互结证患者吗？

6.知柏地黄丸适宜干预2级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者吗？

7.六味地黄丸适宜干预2级高血压阴阳两虚证（偏阴虚）患者吗？

8.济生肾气丸适宜干预2级高血压阴阳两虚证（偏阳虚）患者吗？

9.中成药适宜干预2级高血压患者吗？（至少包含松龄血脉康、珍菊降压片、牛黄降压丸）

10.针刺治疗能降低2级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？

11.推拿能降低2级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？

12.耳穴压豆能降低2级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？

13.中药足浴能降低2级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？

14.传统运动方式能降低2级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？（至少包含太极拳、八段锦、五禽戏）

15.耳尖放血能降低2级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？

中西医结合的治疗时机与策略优化

对于首次就诊时患者西医诊疗盲区的深化处理

16.首诊诊为2级高血压的患者，可否运用中医养生调摄来增强生活方式指导对血压的疗效？

17.首诊诊为2级高血压的患者，可否运用中医药疗法协助控制血压？

18.对于中医疗法意愿强烈的诊为2级高血压首诊患者，如何控制患者血

压？对于血压达标后患者西医剩余风险的优化解决

19.对于化药控制后血压达标但仍存在症状的2级高血压患者，可否运用中医药疗法改善患者症状？

20.对于化药控制后存在副作用或者禁忌的患者2级高血压患者，如何采用中药增效减毒？

21.在改善生活方式的基础上，应用多种降压药物，治疗后血压达标且有减药需求的2级高血压患者如何控制患者血压？

对于血压未达标时患者潜在风险的强化管控

22.在改善生活方式的基础上，血压仍高于160/100mmHg的2级高血压患者如何控制患者血压？

23.在改善生活方式的基础上，应用一类降压药物，血压仍高于160/100mmHg的2级高血压患者如何控制患者血压？

24.在改善生活方式的基础上，应用2类或2类以上降压药物，血压仍高于160/100mmHg的2级高血压患者如何控制患者血压？

6.朱羽硕主治医师进行临床问题确定投票流程和计票规则

7.朱羽硕主治医师进行问题清单投票结果公布

结果显示共计23个问题，投同意票全部＞70%，按照计票规则，该问题＞70%，即直接成为临床问题。（即结束）

8.各位专家对临床问题、共识发表个人意见（专家讨论）

徐浩：第一个问题，证候分型能否优化表述，现代人肝郁证居多，可考虑加上肝郁气滞证；可以依据穴位贴敷治疗高血压建立新问题；如何处理单纯收缩期血压高？血压波动大怎么处理？中医介入时机如何选择？

赵海滨：同意徐浩教授观点，建议证型补充完善，可考虑如何改善患者生活质量。

朱明军：同意各位专家观点，可考虑调整证型，加上肝郁气滞证；耳尖放血多为民间疗法，医疗机构应用不太合适。

李军：2级高血压以西药治疗为主，中医药也有优势，如何突显中医药优势？西药治疗达标后还会有症状，中医药改善症状优势，如何体现中医药优势？高血压常伴有靶器官损伤，怎么有针对性积极预防及治疗，减缓疾病进展？老年人血压忽高忽低，血压常常不稳定，中医药治疗优势，如何体现？西药不良反应居多，

如何在中医药治疗上体现优势？现代人群郁证偏多，容易出现心理障碍问题，中医药治疗有优势，如何体现中医药治疗特色？建议用通俗易懂的语句解释中医概念，让西医同行也能看懂，以便于推广应用。

戴小华：中医特色疗法如运动疗法、足浴疗法可进行推广，而推拿针灸很少用于高血压治疗；20-23 问题可配合中医药疗法；合并靶器官损伤、其他危险因素的患者，中医药如何发挥优势？

李晓鲁：建议对中医特色疗法等补充更多的循证医学证据会更好。

卜培莉：耳尖放血具体操作方法？放多少血？放血频率是多少？放血时间是多久？能降低多少 mmHg？是否对患者产生心理影响，如何疏导？

岳小强：建议证型可以更宽泛一点，证型分类不能太拘泥；西药如何调药？

张玉娇：降压药敏感人群，不好用西药，如何筛选这些人群？是否可依据症状评分等筛选出来？建议说明饮片具体用量、使用方法，这样西医同行可以更好掌握用药。

陈伯钧：证型应当精简，不能太繁琐；什么情况下可配合耳穴压豆、足浴？是着眼于降压还是着眼于改善症状？

王佑华：建议界定清楚应用范围，排除特殊人群。

翟静波：建议调整剂型，比如牛黄降压丸还有片剂等；方案应用时如何兼顾特殊人群？耳穴压豆、足浴、耳尖放血证据不足；

樊管伟：医院操作较为规范，居家操作时影响因素众多，耳尖放血操作应当慎重。足浴降低血压、改善症状，不要强调中医症状。

周雪忠：证型涵盖度怎么样？建议补充完善相关方剂。

谢文：中医药在治疗 2 级高血压有何优势？

张红星：在血压稳定期时，中药、中成药是否可以长期使用，建议说明以便于把握；中成药长期应用的安全性？减药时机是什么时候？

杨佃会：耳尖放血、耳穴压豆作为辅助治疗是可以的，临床上可观察到有较好的降压疗效，但降压时间多长不确定。耳尖放血的放血量取决于手法。

贺立娟：可从身心医学角度挖掘中医药优势，应用抗焦虑、抑郁药降压。

焦华琛：问题 19 增效减毒这个术语引起西医同行反感，建议改为提高疗效。

张磊：不仅应当关注降压幅度，还应当着眼于长期获益。

9.按照专家意见，临床问题清单再次优化，重新投票

1.2 级高血压患者中合并靶器官损伤（心、脑、肾）等危险因素患者如何用中药防治？

2.伴冠心病、糖尿病、心衰、肾功能不全，高脂血症等疾病的 2 级高血压患者，中医药如何参与？

3.穴位贴敷能降低 2 级高血压患者的血压或改善患者的中医症状吗？

4.2 级高血压中的单纯收缩期高血压患者是否适宜中西医结合干预？

5.2 级高血压患者西药降压后血压波动大者是否适宜中西医结合干预？

6.2 级高血压患者的常见证候类型可以归结为肝火亢逆证、阴虚阳亢证、痰湿壅盛证、痰瘀互结证、阴阳两虚证、肝郁气滞证吗？

7.耳尖放血能降低 2 级高血压患者或改善患者的中医症状吗？

10.确定问题清单，同意票数全部＞70%，即直接成为临床问题，共计 7 个问题通过。

11.李运伦教授发表结束语

12.合影

记录整理人：朱羽硕

时　间：2022 年 7 月 2 日

2.《2 级高血压中西医结合诊疗专家共识》第二轮专家会会议纪要

1.时　　间：2022 年 8 月 28 日　19:30-21:00

2.地　　点：山东中医药大学附属医院（腾讯视频会议）

3.参会人员：山东中医药大学附属医院　　李运伦、薛一涛、焦华琛、张磊

山东大学齐鲁医院	卜培莉
河南中医药大学第一附属医院	朱明军
中国中医科学院西苑医院	徐浩
北京中医药大学东方医院	赵海滨、贺立娟
中国中医科学院广安门医院	李军
安徽中医药大学第一附属医院	戴小华
广东省中医院	陈伯钧
上海中医药大学龙华医院	王佑华
天津中医药大学	翟静波
天津中医药大学第一附属医院	樊官伟
南京中医药大学附属医院	王永生
北方交通医院	周雪忠
成都中医药大学第一附属医院	谢文
山东第一医科大学第一附属医院	李晓鲁、张玉娇
海军军医大学长海医院	岳小强
济南市中医医院	张红星
山东中医药大学	杨佃会
复旦大学附属中山医院	刘海波
首都医科大学附属北京朝阳医院	于丽平
解放军总医院第七医学中心	刘春萍

会议纪要

1. 薛一涛教授介绍参会专家与相关领导

2. 翟静波教授作为方法学专家共识相关内容介绍

3. 起草组进行临床问题的投票意见表决情况汇报

起草组成员滑振将全部临床问题将专家的投票表决情况进行分析汇报，并依据国家中医药管理局医政司、中华中医药学会的体例要求，将可归类的临床问题进行合并，与此同时，将证据等级不足的临床问题予以舍弃或剔除。

4. 起草组临床问题起草情况汇报

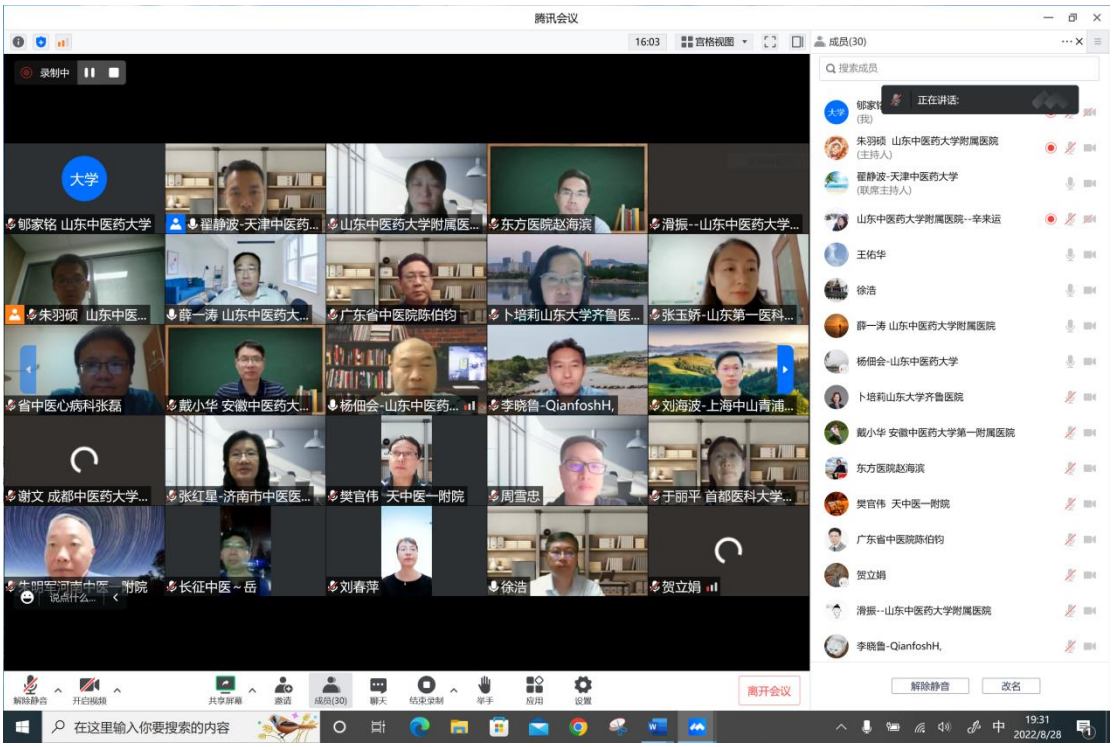
起草组成员朱羽硕分别从版本演变、范围、规范性引用文件、术语和定义、诊断、治疗以及诊疗流程图 7 个方面对《2 级高血压中西医结合诊疗指南》进行分析汇报。

5. 专家意见讨论

参会专家针对其操作的汇报及《2 级高血压中西医结合诊疗指南》草案进行广泛讨论并提出相关意见或建议，起草组进行意见汇总进行后期修改。

6. 卜培莉教授发表结束语

7. 合影



记录整理人：滑振、朱羽硕、辛来运

时　间：2022 年 8 月 28 日

（四）本诊疗方案全部参考文献（即附录 4）

[1] 赵冬. 中国成人高血压流行病学现状 [J]. 中国心血管杂志, 2020, 25(06): 513-5.
[2] WANG Z, CHEN Z, ZHANG L, et al. Status of Hypertension in China: Results from the China Hypertension Survey, 2012-2015 [J]. Circulation, 2018: CIRCULATIONAHA.117.032380.
[3] 《中国心血管健康与疾病报告 2020》编写组. 《中国心血管健康与疾病报告 2020》要点解读 [J]. 中国心血管杂志, 2021, 26(03): 209-18.
[4] 世界卫生组织指南制定手册 [J]. 2013.
[5] 中国高血压防治指南(2018 年修订版) [J]. 中国心血管杂志, 2019, 24(01): 24-56.
[6] 国家基层高血压管理专家委员会. 国家基层高血压防治管理指南 2020 版 [J]. 中国循环杂志, 2021, 36(03): 209-20.
[7] REINER Z, CATAPANO A L, BACKER G D, et al. The european society of cardiology and the european atherosclerosis society (ESC/EAS) guidelines on the management of dyslipidemia [J]. Revista Espanola de Cardiologia, 2011, 64(14): 1168.e1-e60.
[8] 中国高血压防治指南 2010 [J]. 中华心血管病杂志, 2011, (07): 579-616.
[9] 《中国高血压基层管理指南》修订委员会. 中国高血压基层管理指南(2014 年修订版) [J]. 中华高血压杂志, 2015, 23(01): 24-43+15.
[10] 叶明花, 蒋力生, 曹征. 高血压病的中医养生保健 [J]. 江西中医学院学报, 2008, (03): 36-41.
[11] 靳若旭. “活血散风”针刺法治疗 2 级原发性高血压病的疗效评估 [D]; 成都中医药大学, 2020.
[12] 司绍娥, 欧阳晃平. 耳穴埋豆辅助治疗Ⅱ级原发性高血压病 40 例 [J]. 江西中医药大学学报, 2015, 27(01): 49-50+2.
[13] 陈昊昱. 穴位贴敷联合硝苯地平缓释片干预社区高血压(肝阳上亢证)的研究 [D]; 山东中医药大学, 2015.
[14] 黄敏. 中医药治疗湿热蕴结证中青年高血压病 2 级的临床观察 [D];长春中医药大学,2021.
[15] 高阳, 丁碧云. 复方天麻降压颗粒治疗肝阳上亢型高血压及血压变异性临床观察 [J]. 中医药临床杂志, 2017, 29(04): 510-4.
[16] 祁金涛. 复方天麻降压颗粒治疗阴虚阳亢证高血压晨峰现象的临床观察 [D]; 安徽中医药大学, 2018.
[17] 马诺莎. 潜阳育阴颗粒对高血压患者血压短时变异性的影响 [D]; 南京中医药大学, 2013.
[18] 王宝宝. 邓老石决牡蛎汤对高血压病血压变异性及临床疗效的影响 [D]; 广州中医药大学, 2013.
[19] 林建珍, 姚月娴, 林金秀. 高血压患者发生心血管事件危险因素的探讨 [J]. 中国循环杂志, 2010, 25(06): 456-9.
[20] 韩璐, 宋舜尧, 王梦楠, 等. 替米沙坦联合复方丹参滴丸对原发性老年 2 级高血压患者血压及血管内皮功能的影响 [J]. 安徽医药, 2018, 22(02): 352-5.
[21] 江钰, 王洪霞. 中药穴位贴敷治疗老年高血压病 100 例临床疗效分析 [J]. 新疆中医药, 2019, 37(05): 20-2.
[22] 杜敏, 李莉, 吕鹏, 等. 天麻钩藤颗粒联合替米沙坦对原发性老年 2 级高血压 Klotho 蛋白水平的影响 [J]. 广州中医药大学学报, 2020, 37(02): 206-12.
[23] 丁洪涛, 朱梦莉, 罗毅. 中西医结合分级治疗老年高血压病临床观察 [J]. 浙江中西医结合杂志, 2005, (06): 333-5.
[24] 孙清廉. 血压波动更危险 [J]. 健康生活, 2013, (10): 10-1.
[25] 杨国君. 高血压降压达标的内涵 [J]. 中华高血压杂志, 2007, (09): 786-9.
[26] 梁晨光. 钩藤四物汤治疗中老年轻、中度高血压临床疗效观察 [D]; 山东中医药大学, 2011.
[27] 孟玲玲. 活血柔肝法对老年高血压患者血压波动性的影响 [D]; 河南中医学院, 2015.
[28] 赵华云, 黄嘉文, 王文会, 等. 半夏白术天麻汤干预治疗肥胖型高血压疗效观察 [J]. 辽宁中医药大学学报, 2016, 18(12): 14-7.

[29] 李平宝. 血府逐瘀胶囊治疗瘀血阻络型高血压病的效果及对血压水平影响观察 [J]. 黑龙江中医药, 2019, 48(02): 40-1.
[30] 孙伯青. 血府逐瘀胶囊干预高血压病左室舒张功能及心室重构的临床研究 [J]. 南京中医药大学学报, 2009, 25(01): 24-6.
[31] 郑亚威, 李婕, 姚文强, 等. 活血化瘀类口服中成药治疗高血压病左心室肥厚的网状 Meta 分析 [J]. 中国中药杂志, 2022, 47(05): 1383-91.
[32] 安晓娜. 中医药治疗高血压早中期肾损害有效性和安全性的 meta 分析 [D]; 北京中医药大学, 2019.
[33] 徐晓雨, 龚帆影, 张春芹, 等. 潜阳育阴颗粒对阴虚阳亢型高血压合并高脂血症患者血管弹性功能的影响 [J]. 南京中医药大学学报, 2021, 37(06): 865-70.
[34] 张鹏. 解毒通络调肝降压方治疗 2 型糖尿病合并高血压病的临床观察 [D]; 长春中医药大学, 2020.
[35] 吴迪, 李克明. 半夏白术天麻汤合丹参酮对痰瘀阻络型糖尿病合并高血压患者干预作用的临床研究 [J]. 世界中西医结合杂志, 2018, 13(03): 414-7.
[36] 孙楠楠. 加味天麻钩藤饮治疗社区高血压的疗效评价：诊室血压研究 [D]; 山东中医药大学, 2017.
[37] 李晓霞. 补肾和脉颗粒对老年 H 型单纯收缩期高血压同型半胱氨酸水平的干预作用 [D]; 山东中医药大学, 2016.
[38] 王震. 补肾和络方辨治老年单纯收缩期高血压的随机对照研究 [D]; 山东中医药大学, 2007.
[39] 潘青腾. 柴胡疏肝散加减治疗原发性高血压肝气郁结证的临床研究 [D]; 山东中医药大学, 2015.
[40] 刘晓利. 半夏白术天麻汤联合西药治疗对原发性高血压患者血清 Hcy、CysC 和 UA 水平的影响 [J]. 现代中西医结合杂志, 2016, 25(32): 3584-6.
[41] 吴子君. 半夏白术天麻汤辅助治疗原发性高血压的效果及对血清 Hcy、CysC 和 UA 水平的影响 [J]. 慢性病学杂志, 2019, 20(07): 1104-6.
[42] 李航. 半夏白术天麻汤联合缬沙坦胶囊治疗高血压病（痰湿壅盛证）的临床研究 [D]; 辽宁中医药大学, 2013.
[43] 穆善生. 半夏白术天麻汤联合硝苯地平对老年高血压的治疗效果 [J]. 河北医药, 2020, 42(24): 3746-9.
[44] 陈建兴, 苏志远. 半夏白术天麻汤联合厄贝沙坦氢氯噻嗪片治疗高血压临床效果观察 [J]. 现代诊断与治疗, 2019, 30(16): 2746-7.
[45] 马惠倪, 苏伟, 夏晶晶, 等. 半夏白术天麻汤治疗原发性高血压风痰上扰证的临床研究 [J]. 世界中西医结合杂志, 2019, 14(11): 1579-83.
[46] 叶盈, 黄飞翔, 王永, 等. 六味地黄丸合络活喜治疗女性更年期高血压疗效观察 [J]. 中国中医急症, 2006, (05): 487-8.
[47] 袁静雨. 六味地黄丸联合规范西药治疗对肝肾阴虚型老年高血压患者生存质量影响的临床观察 [D]; 成都中医药大学, 2020.
[48] 宋凯, 王亚军, 熊凡捷, 等. 补阴针法结合缬沙坦治疗阴虚阳亢型原发性 2 级高血压病临床疗效观察 [J]. 辽宁中医杂志, 2021, 48(06): 210-3.
[49] 段佳佳, 李瑞蓉, 胡守喜, 等. 针刺对中度高血压患者 ApoA、ApoB、Lp(a)的影响 [J]. 山西中医, 2015, 31(11): 37-8.
[50] 侯一静. 穴位按摩联合硝苯地平缓释片干预社区高血压（阴虚阳亢证）的研究 [D]; 山东中医药大学, 2014.
[51] 孟晓东, 张振宇, 范肃. 硝苯地平加用推拿手法治疗肝火亢盛证原发性高血压 40 例 [J]. 环球中医药, 2013, 6(07): 536-8.
[52] 张翠君. 原发性高血压病人给予中医推拿治疗的效果观察 [J]. 心理月刊, 2019, 14(05): 151.
[53] 林成杰. 推拿治疗轻中度高血压的临床研究 [D]; 山东中医药大学, 2005.
[54] 王美芝. 择时自我推拿对社区 1、2 级高血压病患者临床疗效的影响 [J]. 中国民间疗法, 2021, 29(13): 73-5.
[55] 苏宝兰. 穴位按摩对肝阳上亢型高血压患者的疗效观察 [J]. 中国冶金工业医学杂志, 2021, 38(04): 378-9.

[56] 马英莉. 济南南辛庄社区高血压患者穴位按摩联合硝苯地平缓释片干预研究 [D]; 山东中医药大学, 2015.
[57] 骆传江, 徐龙华. 中医推拿与西药治疗高血压各 50 例临床观察 [J]. 按摩与导引, 2002, (01): 16-7.
[58] 于澎, 李文夫, 徐惠, 等. 耳穴压籽法治疗原发性高血压病 100 例临床观察 [J]. 黑龙江中医药, 1988, (04): 29-31.
[59] 努尔比亚·买买提明. 耳穴贴压疗法对女性高血压病（更年期）患者血压变异性的影响 [D]; 新疆医科大学, 2010.
[60] 周荣兴, 张燕华, 常红. 耳穴贴压治疗高血压 135 例降压效应的动态观察 [J]. 上海针灸杂志, 1993, (02): 62-3.
[61] 何定峰. 珍菊降压片治疗原发性高血压临床疗效观察 [J]. 中国医药导报, 2012, 9(13): 71-2.
[62] 侯加洲. 珍菊降压片治疗原发性高血压 42 例临床疗效 [J]. 中国现代药物应用, 2010, 4(12): 158-9.
[63] 盛东平. 珍菊降压片联合厄贝沙坦片治疗高血压的临床疗效观察 [J]. 海峡药学, 2013, 25(01): 141-2.
[64] 吴汉卿, 黄召谊, 杨芙蓉, 等. 松龄血脉康对高血压病患者血液流变性及甲襞微循环的影响 [J]. 微循环学杂志, 2002, (04): 31-3+0-67.
[65] 张仲华, 纪别克, 王晋, 等. 松龄血脉康治疗 42 例老年人高血压并脑梗塞降压疗效观察 [J]. 石河子医学院学报, 1997, (03): 203-5.
[66] 于艳.松龄血脉康胶囊联合苯磺酸氨氯地平对肝阳上亢型高血压病人血浆 MDA、NOS、SOD 活性及血压变异性的影响[J].中西医结合心脑血管病杂志,2019,17(07):986-989.
[67] 李卓远. 松龄血脉康胶囊联合左旋氨氯地平治疗原发性高血压疗效分析 [J]. 中医药临床杂志, 2017, 29(04): 515-7.
[68] 王燎, 乔柯. 松龄血脉康胶囊与硝苯地平控释片治疗原发性高血压的对比 [J]. 华西药学杂志, 2006, (01): 107-8.
[69] 王锋, 康健. 松龄血脉康胶囊治疗原发性高血压 45 例临床观察 [J]. 中国民间疗法, 2004, (06): 57-8.
[70] 蔡秉惠. 牛黄降压丸联合卡托普利治疗原发性高血压疗效观察 [J]. 天津药学, 2009, 21(04): 36-7.
[71] 周端求, 周海燕, 杨铮铮, 等. 牛黄降压丸治疗原发性高血压的临床研究 [J]. 中国中药杂志, 2006, (07): 612-4.
[72] 丁小芳. 牛黄降压丸治疗高血压随机平行对照研究 [J]. 实用中医内科杂志, 2013, 27(14): 58-60.
[73] 洪建康, 侯晓亮, 陈浩生, 等. 心可舒联用拉西地平治疗单纯收缩期高血压 [J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2015, 13(11): 1308-9.
[74] 田采红. 心可舒胶囊配合倪福达对高血压病（气滞血瘀型）临床疗效观察 [D]; 山西中医学院, 2014.
[75] 金涛, 葛慧莉, 孔庆军. 心可舒胶囊联合厄贝沙坦改善老年高血压病合并高脂血症患者血压、血脂及炎性因子的效果观察 [J]. 临床误诊误治, 2020, 33(12): 25-8.
[76] 陈刚, 宋敏, 孙小东. 苯磺酸氨氯地平联合心可舒治疗高血压的临床观察 [J]. 中国药房, 2016, 27(15): 2054-6.